



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Medicina

Escuela Profesional de Enfermería

Percepción de riesgo de la Diabetes mellitus tipo II en adultos que acuden a un Centro de Salud de San Juan de Lurigancho, 2024

TESIS

Para optar el Título Profesional de Licenciada en Enfermería

AUTOR

LEZAMETA ESTACIO, Gianella Deyna Verónica

ASESOR

Dr. Jhon Alex ZELADITA HUAMAN

Lima, Perú

2024

RESUMEN

Introducción: La diabetes mellitus tipo II es una enfermedad prevenible cuya incidencia en la población peruana está en aumentando cada año. Sin embargo, se ha encontrado escasas investigaciones en el Perú que determinen la percepción de riesgo de esta enfermedad, así como un instrumento validado para medir esta variable. Este constructo es importante porque representa una valoración subjetiva de los factores riesgos influenciada por las ideas, pensamientos, conocimientos y experiencia de cada individuo; y está estrechamente relacionada con el cumplimiento de las medidas preventivas.

Objetivo: Determinar percepción de riesgo de la diabetes mellitus tipo II en adultos que acuden a un Centro de Salud de San Juan de Lurigancho, 2024.

Metodología: Estudio de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de método descriptivo y de corte transversal. Se realizó la aplicación de la escala de Likert de manera presencial en adultos que asisten al centro de salud Zárate del distrito de San Juan de Lurigancho. La muestra estuvo constituida por 300 usuarios.

Resultados: El nivel de percepción de riesgo de los adultos que acuden a un Centro de Salud en San Juan de Lurigancho fue medio con 55,3% (166) y bajo con 38,3% (115). En la dimensión sesgo optimista predominó el nivel de percepción de riesgo medio con 44,3%, similar que en la dimensión preocupación, con 56% con percepción de riesgo medio, a diferencia de la dimensión control interno y externo, donde el 56% obtuvo nivel de percepción bajo.

Conclusiones: Los adultos usuarios de un establecimiento de salud del primer nivel de atención muestran un nivel moderado de percepción de riesgo de la Diabetes. El estudio evidenció una subestimación de la probabilidad de desarrollar diabetes, y, aunque existe preocupación, esta, al no estar equilibrada con el control interno, podría ser contraproducente, reflejando inacción y falta de implementación de medidas preventivas. Por lo tanto, es fundamental concientizar sobre los factores de riesgo reales y fomentar la adopción de medidas preventivas frente a los riesgos modificables de la enfermedad. Finalmente, es importante canalizar la preocupación como un impulso para promover y adoptar acciones preventivas.

Palabras claves: Percepción, riesgo, adulto, diabetes tipo 2.

ABSTRACT

Introduction: Type II diabetes mellitus is a preventable disease whose incidence in the Peruvian population is increasing every year. However, there has been little research in Peru to determine the perceived risk of this disease, as well as a validated instrument for measuring this variable. This construct is important because it represents a subjective assessment of risk factors which is influenced by the ideas, thoughts, knowledge and experience of each individual; and is closely related to the implementation of preventive measures.

Objective: To determine the risk perception of type 2 diabetes mellitus in adults attending a health center in San Juan de Lurigancho in 2024.

Methods: A quantitative study with a non-experimental, descriptive, and cross-sectional design. The Likert scale was administered in person to adults attending the Zárate Health Center in the district of San Juan de Lurigancho. The sample consisted of 300 participants.

Results: The level of risk perception among adults attending a health center in San Juan de Lurigancho was moderate at 55.3% (166) and low at 38.3% (115). In the optimistic bias dimension, the predominant level of risk perception was moderate at 44.3%, similar to the concern dimension, which also showed a moderate risk perception at 56%. In contrast, the internal and external control dimension had 56% of participants with low risk perception.

Conclusions: Adults using a primary care facility show a moderate level of risk perception for diabetes. The study evidences of an underestimation of the likelihood of developing diabetes, and while concern exists, this may be counterproductive if not balanced with internal control, reflecting inaction and a lack of preventive measures. Therefore, it is essential to raise awareness of actual risk factors and to encourage the adoption of preventive measures against the modifiable risks of the disease. Finally, it is important to channel concern as a driving force to promote and adopt preventive actions.

Keywords (5): Perception, risk, adult, type 2 diabetes.

DEDICATORIA

A Dios, por la sabiduría y escuchar siempre mis oraciones, por guiarme en el camino y darme las habilidades necesarias para ser instrumento de buenas acciones a lo largo de mi carrera.

A mi madre, por haberme dado las bases fundamentales y principios en mi formación individual, así como la determinación para cumplir mis objetivos.

A mi padre, por brindarme su apoyo y confianza incondicional, por ser paciente y darme energía positiva a lo largo del camino.

A mi hermana Cindy y mi cuñado Elis, por el apoyo incondicional a lo largo de mis estudios, por brindarme apoyo cuando más lo necesité.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y a los docentes que estuvieron en mi formación académica, por introducir diariamente conocimientos fundamentales, así como la disciplina y moral para llevarlo a cabo a lo largo de la profesión.

A mi asesor Dr. Jhon Zeladita Huaman, por su presencia y apoyo a pesar de las dificultades.

A mis mejores amigos Tomás y André, por ayudarme en fortalecer mi carácter para seguir perseverando con tranquilidad y salud mental.

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN	1
1.1. Planteamiento del problema	3
1.1.1. Formulación del problema	8
1.2. Objetivos	8
1.3. Importancia y alcance de la investigación	9
1.4. Limitaciones del estudio	10
II. REVISION DE LITERATURA	12
2.1. Antecedentes del estudio	12
2.2. Bases teóricas	18
2.2.1. Diabetes Mellitus	18
2.2.2. Percepción de Riesgo	25
2.2.3. PERCEPCIÓN DE RIESGO PARA LA DIABETES MELLITUS TIPO 2	28
2.2.4. Rol de Enfermería	32
2.3. Definición operacional de términos	35
III. HIPOTESIS Y VARIABLES	36
3.1. Variable	36
IV. MATERIAL Y METODOS	37
4.1. Tipo de estudio y método de investigación	37
4.2. Diseño de investigación	37
4.3. Sede de Estudio	37
4.4. Población, muestra y muestreo	38
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	39
4.6. Procedimientos de recolección de datos	41
4.7. Análisis estadístico	41

4.8. Consideraciones éticas	42
V. RESULTADOS	43
VI. DISCUSIÓN	52
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	59
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	62
ANEXOS	72
ANEXO A: Operacionalización de la variable	74
ANEXO B: Formula de población finita	77
ANEXO C: Instrumento	78
ANEXO D: Informe de Juicio de Experto	81
ANEXO E: Libro de códigos	82
ANEXO F: Matriz de datos	85
ANEXO G: Consentimiento Informado	89
ANEXO H: Tablas	90

ÍNDICE DE TABLAS

Tablas	Página
1. Datos generales de personas adultas que acuden a un Centro de salud en San Juan de Lurigancho, 2024.	90
2. Indicadores de la percepción de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2 de la dimensión sesgo optimista, en adultos que acuden a un Centro de salud en San Juan de Lurigancho, 2024.	41
3. Indicadores de la percepción de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2 de la dimensión control interno y externo, en adultos que acuden a un Centro de salud en San Juan de Lurigancho, 2024.	43
4. Indicadores de la percepción de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2 de la dimensión preocupación, en adultos que acuden a un Centro de salud en San Juan de Lurigancho, 2024.	46

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico	Página
1. Percepción de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2 en adultos que acuden a un Centro de Salud de San Juan de Lurigancho, 2024	39
2. Percepción de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2 en la dimensión sesgo optimista en adultos que acuden a un Centro de Salud de San Juan de Lurigancho, 2024	40
3. Percepción de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2 en la dimensión sesgo control interno y externo en adultos que acuden a un Centro de Salud de San Juan de Lurigancho, 2024	42
4. Percepción de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2 en la dimensión preocupación en adultos que acuden a un Centro de Salud de San Juan de Lurigancho, 2024	45

I. INTRODUCCIÓN

1.1. Planteamiento del problema

Las enfermedades no transmisibles (ENT) son aquellas que la persona padece fundamentalmente a causa de su estilo de vida, tales como la alimentación, actividad física, exposición al tabaco y/o alcohol, etc. Según la OMS las ENT son causantes de 41 millones de muertes al año, es decir el 71% de muertes, de las cuales 15 millones son en personas entre 30 y 69 años. Entre las enfermedades que ocasionan mayor mortalidad son las cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes mellitus (1). La diabetes mellitus (DM) se caracteriza por los niveles de azúcar elevados en sangre, existen dos tipos de diabetes, la diabetes mellitus tipo 1 (DM1) y tipo 2 (DM2) donde esta última se da por una alteración disfuncional en las células beta del páncreas (2) y abarca el 90% de diagnósticos entre ambos tipos (3) (4). Según la OMS 2000 y 2016, la mortalidad temprana por diabetes se incrementó en un 5% y en el 2019 la diabetes fue la novena causa de muerte más importante con 1,5 millones de fallecimientos, a su vez la incidencia hasta el 2019 es de 2 personas por cada 100 anualmente (5) Según ENDES 2022 el 5,1% de la población mayor de 15 años alguna vez ha sido diagnosticada por un médico de Diabetes mellitus, que en mayor proporción la DM2 abarca el 90% de estos diagnósticos. (ENDES)

Los factores de riesgo de la DM2 son numerosos e incluyen: socioeconómicos, demográficos, ambientales y genéticos. Estos suelen clasificarse en factores no modificables y modificables, entre los primeros, Llorente, et al. (6), determinó que los antecedentes familiares son los principales, en Colombia, Rodríguez (7) encontró asociación significativa entre el riesgo de adquirir la enfermedad y el sexo femenino así como una edad por encima de los 45 años. Por otro lado entre los factores de riesgo

modificables, prevenibles o tratables, están los estilos de vida no saludables, el déficit de actividad física o sedentarismo, fumar, bajo consumo de frutas y verduras, etc., estos son considerados importantes para el primer nivel de salud, ya que los profesionales de enfermería pueden intervenir en promoción de la salud y prevención de estas enfermedades. En relación con otras ENT, se tiene al sobrepeso/obesidad, hipertensión arterial e hiperlipidemia; por último en el ámbito socioeconómico, el bajo nivel educativo y adquirir un salario inferior al mínimo. (7) (3) (8).

Según la Federación Internacional de Diabetes resume que los factores de riesgo que contribuyen a la incidencia de la enfermedad sería la urbanización, población que envejece, disminución de actividad física, aumento de prevalencia de sobrepeso y obesidad y todo lo que lleva a estas últimas mencionadas (9).

La DM2 tiene como complicaciones, a la pérdida de la visión, alteraciones de los riñones, enfermedades cardiovasculares, problemas cerebrales entre otros (10), si bien es inevitable que las personas con la enfermedad no tengan ninguna complicación, la aparición de estas puede retrasarse con adecuada adherencia al tratamiento, adquisición de conocimientos y prácticas prevenibles.

Los factores que determinan que una persona prevenga la DM2, son los conocimientos sobre sus factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad y la de sus complicaciones, pues los factores de riesgo innatos de una persona (antecedentes familiares) asociados a hábitos no saludables, lo llevarían a desencadenar la enfermedad (11). Sin embargo no solo es el conocimiento importante para prevenirla sino también la percepción de riesgo que tenga la persona, pues esta es un acercamiento a la realidad que ellos perciben, ello tiene relación según el primer patrón de la etapa de Valoración según

Marjory Gordon (12), donde se resalta la relevancia de cómo el individuo percibe su estado de salud ya sea que esta esté alterada o no. (13)

La percepción del riesgo de la diabetes se tiene gracias a los conocimientos previos, experiencias y punto de vista en base a su estilo de vida, estado de salud y entorno, pues es el conjunto de recepción e interpretación de cualquier estímulo sensorial del individuo y dependerá de si lo reconoce o distingue, para poder interpretarla en base a conocimientos previos, contexto y emociones (14) (15). En la etapa de la adultez, estas características pueden determinar decisiones para poder adoptar recomendaciones, sugerencias o consejerías que se le puede brindar según el modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender, donde el profesional de enfermería tiene el deber de intervenir en el control de la salud, brindando conocimientos y fomentando comportamientos realizables para prevenir enfermedades (16) (17), o también en las intervenciones según la teoría del déficit de autocuidado de Dorothea Orem, pues dependerá del nivel de autocuidado que tenga el paciente para aportar brindar conocimientos suficientes para ayudar al individuo a recuperar o mantener su autonomía (17).

Diversas investigaciones han abordado la percepción de riesgo de la DM2. Un estudio realizado en Nápoles a padres de niños que asisten a escuelas públicas se obtuvo que de 527 padres el 97,3% han oído hablar de la diabetes, pero solo el 16,7% conoce los principales factores de riesgo y protección, la percepción de riesgo fue menor en personas con nivel de educación media o secundaria, en comparación con una percepción más acorde con aquellos que tenían título universitario o educación superior (18). En Cuba realizaron un estudio con el objetivo de determinar la percepción de riesgo de la diabetes mellitus en personas no diabéticas, donde se concluye que, de 1145 personas, el 59,2% de los participantes tuvieron percepción de riesgo, teniendo en cuenta que el 80,5 % de

mujeres y el 78,5% de varones respondieron afirmativamente a la pregunta sobre obesidad y sobrepeso (19).

En Estados Unidos con el fin de explorar el conocimiento de la diabetes y la percepción del riesgo de enfermedad futura de los estudiantes universitarios, se hizo un estudio en 697 estudiantes, donde se tuvo como resultado que más el 90% percibió riesgo de diabetes como bajo o moderado, y los que se autoevaluaron como salud buena/excelente y leyeron las etiquetas de los alimentos regularmente a menudo tenían un menor riesgo futuro percibido de diabetes (20). Así mismo en otra investigación realizada en Nueva York, resaltan que el riesgo percibido se correlaciona positivamente con el IMC, aunque en el mismo se halló que la percepción de riesgo de estudiantes con o sin antecedentes familiares, tienen el mismo nivel de percepción (21).

De estos hallazgos se puede afirmar que la percepción de riesgo es influenciada por experiencias personales, antecedentes y nivel de educación, sin embargo, se necesita más investigaciones que ayuden en la exploración de predictores de la percepción de riesgo del desarrollo de la enfermedad.

Los profesionales de enfermería son un ente importante en el primer nivel de atención, para promocionar un adecuado estilo de vida y prevenir enfermedades, entre ellos a la diabetes mellitus, según el nivel de prevención, pues en la historia natural de la enfermedad se aborda una protección específica y en la prevención secundaria, un diagnóstico oportuno (7), es por ello que la percepción orienta a poder implementar intervenciones oportunas en la promoción de la salud y prevención de la diabetes mellitus 2, ya que la percepción es la interpretación de todo el entorno tanto social cultural y ambiental (22).

En base a lo descrito, se recolectó información o comentarios de adultos del centro de salud Zárate. sobre qué es lo que perciben de la diabetes y dijeron: “es una enfermedad que puede ser genética pero depende de lo que uno come, así que hay que cuidarse” “yo creo que las personas que son gorditas tienen esa enfermedad porque luego bajan de peso rápido así que hay que cuidar el peso” “...de una amiga toda su familia de parte papá tenía diabetes, pero ella hasta ahora no tiene, lo que sí es que a veces sufre de la presión pero de ahí no tiene así que no es genético o a ella no le tocó, no sé mucho de la enfermedad pero eso es lo que puedo decir.”

De lo mencionado, las interrogantes serían: ¿Cómo perciben los usuarios del C.S. Zárate de la enfermedad Diabetes mellitus tipo 2? ¿Creerán que es importante saber los factores de riesgo? ¿Los conocimientos previos de la enfermedad habrán aportado en su percepción de la enfermedad? ¿Será su percepción diferente de aquellos que tienen antecedentes familiares de los que no?

1.1.1. Formulación del problema

¿Cuál es la percepción de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2 en adultos que acuden a un centro de salud de San Juan de Lurigancho, 2024?

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General:

Determinar percepción de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2 en adultos que acuden a un centro de salud de San Juan de Lurigancho, 2024

1.2.2. Objetivos Específicos:

- Identificar percepción de riesgo en la dimensión sesgo optimista que tienen los adultos que acuden a un centro de salud de San Juan de Lurigancho entre los meses julio y agosto del 2024.
- Identificar percepción de riesgo en la dimensión control personal interno y externo que tienen los adultos que acuden a un centro de salud de San Juan de Lurigancho entre los meses julio y agosto del 2024.
- Identificar percepción de riesgo en la dimensión preocupación que tienen los adultos que acuden a un centro de salud de San Juan de Lurigancho entre los meses julio y agosto del 2024.

1.3. Importancia y alcance de la investigación

La percepción del riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 (DM2) es un factor clave en las decisiones de los pacientes, ya que refleja la vulnerabilidad que sienten frente a la enfermedad. Esta percepción influye directamente en su comportamiento para reducir el riesgo de desarrollar la DM2, motivando acciones preventivas. (23), es por ello que los profesionales de la salud como primera línea en la prevención y promoción de la salud, deben considerar la percepción de riesgo en sus pacientes. No solo es importante que las personas conozcan los riesgos, sino que se involucren activamente para aplicar las recomendaciones en su vida diaria, adaptándolas a su estilo de vida, cultura, entorno laboral, social y ambiental.

Este estudio ofrecerá información valiosa sobre la percepción del riesgo de desarrollar DM2 en adultos no diabéticos, lo que contribuirá a mejorar las estrategias preventivas. En Latinoamérica, existen pocos estudios sobre diabetes, a pesar de que entre el 8% y el 13% de la población padece la enfermedad, y el 40% desconoce su condición. Esto ha provocado un aumento anual en la tasa de morbilidad. Además, la prediabetes, que precede a la diabetes tipo 2 (DM2), afecta entre el 6% y el 14% de la población y está relacionada con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Esto resalta la urgencia de implementar tratamientos, control y fortalecer los programas de salud pública para crear conciencia sobre la enfermedad. (24).

El Perú también enfrenta una escasez de investigaciones sobre diabetes, a pesar de que los habitantes de áreas urbanas tienen 4,3 veces más probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2 en comparación con los residentes de zonas rurales. Esto sugiere la necesidad de una mayor atención y estudios en el contexto local para comprender mejor los factores de riesgo y diseñar estrategias de prevención adaptadas a la realidad peruana.

(25) En este contexto, la presente investigación representa un aporte relevante para futuros estudios en la profesión, enfocándose en la prevención de las Enfermedades No Transmisibles (ENT). Su objetivo es contribuir al conocimiento y al desarrollo de estrategias preventivas que aborden los factores de riesgo asociados a la diabetes, ayudando a reforzar la capacidad de respuesta del sistema de salud pública. Esta investigación busca ser un referente para nuevas iniciativas y estudios enfocados en la prevención y el control de esta enfermedad.

Además, en este estudio se validará la **Encuesta de Percepción de Riesgo para el Desarrollo de Diabetes (RPS-DD)**, que se mide en una escala Likert y es válida tanto en español como en inglés. Esta validación permitirá que la herramienta sea accesible para futuras investigaciones en el contexto peruano, facilitando la recolección de datos sobre la percepción de riesgo de diabetes en la población local y contribuyendo al desarrollo de estudios orientados a la prevención de esta enfermedad. (26)

I.4. Limitaciones del estudio

Los escasos estudios en las dimensiones de sesgo optimista y preocupación, de la percepción de riesgo, tanto en el Perú como en Latinoamérica no permiten hacer una comparación relevante y actualizada de esta investigación con otras, por lo que se tuvo que tomar investigaciones de otros países, con culturas y estatus social diferente a la población de estudio, así mismo no se encontró una escala o instrumento validado en la población peruana.

II. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1. Antecedentes del estudio

Jia Guo, et al. (27) en 2019, China, realizaron un estudio con el objetivo de comparar el riesgo percibido y real, de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 para madres de niños en edad preescolar en zonas urbanas de China, este es de corte transversal, la muestra poblacional fue de 176 madres, con edad media 31 años. Conclusión:

“Casi el 90% de las madres tuvieron una percepción casi nula o muy baja, a pesar de que casi el 50% tenían padres o hermanos con diabetes. Por dimensiones de la percepción, las madres sedentarias, obtuvieron mayor percepción en Preocupación, y las que acompañan el sedentarismo con menor actividad física, tienen menor percepción en control interno, por último, las madres mayores o que realizaban alguna actividad física tenían sesgo más optimista.”

Angelina P. Nguyen (23) en 2020, realizaron una investigación titulada “Percepción del riesgo de desarrollar diabetes: en análisis conceptual”. El objetivo de esta investigación fue analizar dimensiones del riesgo percibido de la diabetes, entre ellas la probabilidad percibida, el riesgo personal, el riesgo general, riesgo cognitivo, emocional, comparativo y optimismo poco realista. La investigación fue cualitativa y se utilizó análisis conceptual mediante el enfoque de Walker y Avant, se seleccionaron 23 artículos. Las conclusiones de este estudio:

“Los antecedentes del riesgo percibido eran factores motivacionales, diferencias particulares, el contexto, los conocimientos y factores afectivos. El optimismo poco realista es reflejado en una baja percepción de riesgo. Una consecuencia de la percepción del riesgo de la DM2 fue la adopción de conductas que promueven la salud” (23).

Khan, Raihan et al. (20), en el 2020, Estados Unidos, realizaron un estudio que tiene el título de “Predictores de la percepción del riesgo de diabetes entre estudiantes

universitarios”. El objetivo fue determinar los conocimientos de la diabetes y la percepción de riesgo de esta, siendo los predictores de la percepción del riesgo los antecedentes familiares, conductas de salud personal y control percibido sobre los factores de riesgo. La muestra fue tomada por conveniencia conformada por 697 estudiantes de una universidad estatal, del estudio se obtuvo como conclusiones:

“La mayoría percibieron que tenía bajo riesgo de desarrollar la enfermedad, así mismo que los que tenían mayor conocimiento de la enfermedad tenían más probabilidades de percibirse con mayor riesgo de desarrollar a futuro la diabetes” (20).

Koipuram et al. (28) en el 2020 realizaron una investigación que lleva por título “Conocimiento de la diabetes, percepción del riesgo y calidad de vida entre los cuidadores del sur de Asia en la edad adulta joven” con el objetivo de relacionar el conocimiento de la DM2, la calidad de vida, la percepción de riesgo y el riesgo real de desarrollar diabetes en adultos jóvenes del sur de Asia que tiene padres con DM2. El tipo de estudio fue cuantitativo descriptivo de corte transversal y tuvo como muestra 149 adultos jóvenes (76 mujeres y 73 varones), donde se obtuvo como conclusiones:

“el 32,5% de mujeres y 11% de varones participaron en la administración de insulina a sus padres; el 55,3% de mujeres y el 17,8% de varones manejaron complicaciones como heridas, niveles de glucosa bajo, daño nervioso entre otros. El 20,5% de los varones y 34,2% de mujeres tenían una alta percepción de riesgo, sin embargo, los varones son los que tenían mayor riesgo de desarrollar la enfermedad.” (28).

Sulaimán et al. (29) en la investigación realizada en el 2020 “Percepción de riesgo y conocimiento sobre diabetes en hijos de diabéticos tipo 2 en una institución de tercer nivel” tuvieron el objetivo de determinar el riesgo percibido de desarrollar DM2 y su conocimiento entre los hijos de pacientes diabéticos. La muestra estuvo constituida por

336 estudiantes de pre y post grado de la Universiti Kebangsaan Malaysia en el 2018. El estudio es de corte transversal y se tuvo como conclusiones:

“el 56,5% identificó de manera correcta el riesgo de desarrollar la enfermedad y el 52,7% tiene un conocimiento adecuado, así mismo los de sexo masculino tenían mejor percepción que las mujeres” (29).

Khlaifat, Ali M., et al. (30) realizaron un estudio exploratorio de corte transversal titulado “Encuesta transversal sobre el conocimiento, las percepciones de riesgo y las prácticas sobre diabetes entre estudiantes universitarios en el sur de Jordania”. Esta tuvo como objetivo medir el conocimiento, la percepción del riesgo y la práctica de la diabetes en siete universidades del sur de Jordania. Para este estudio consideraron un total de tres mil participantes de las cuales al final se obtuvieron 2158 encuestas óptimas para análisis (1031 varones y 1127 mujeres), donde se concluye:

“la percepción fue moderada en 52,5% y en la práctica fue ligeramente superior en 61,9%. Los estudiantes sin antecedentes pero que cuidan a alguien con la enfermedad predijeron significativamente la percepción de riesgo de DM” (30).

Alzaben, Abeer S., et al. (31) realizaron la investigación de corte longitudinal entre el 2020 y 2021 en la Universidad Princesa Nourah bint Abdulrahman, Riad, Arabia Saudita titulada “La influencia de un programa de concientización sobre la diabetes en el conocimiento, percepción de riesgos y las prácticas sobre diabetes entre estudiantes universitarios”. Este tiene como objetivo comparar el conocimiento sobre la DM, la percepción de riesgo y las prácticas de salud antes y después de un programa de concientización. En el estudio participaron 558 estudiantes y se obtuvo las siguientes conclusiones:

“Los conocimientos fueron significativamente más altas después del programa, igual que la puntuación de la práctica moderada, sin

embargo, no se obtuvieron diferencias en la percepción de riesgo antes y después del programa.” (31).

Antwi, Janet, et al. (21) realizaron un estudio piloto titulado “Percepción y factores de riesgo de diabetes tipo 2 entre estudiantes que asisten a una universidad del norte del estado de Nueva York”. El objetivo de esta es generar datos preliminares sobre la percepción de la DM2 y determinar la prevalencia de los factores de riesgo entre los estudiantes. En esta investigación de corte transversal realizado en el 2020 participaron 44 estudiantes de donde se obtuvieron perfiles metabólicos, datos sociodemográficos y antropométricos, así como conocimientos sobre nutrición y seriedad y autoeficacia percibida. Las conclusiones fueron:

“Se obtuvo que casi el 30% de participantes percibía que no se sentían seguros de poder prevenir la enfermedad. La mayoría de los estudiantes con glucemia alta en ayunas alterada, percibieron bajo riesgo de desarrollar DM2, al igual que los estudiantes con y sin antecedentes familiares.” (21).

Jimenez, Karla, et al. (32), realizaron un estudio en México que llevó por título “Percepción de riesgo socio ecológico para diabetes tipo 2 en adultos mexicanos”. Esta investigación descriptiva transversal tuvo como muestra 268 adultos entre 18 a 59 años, donde predominó el sexo femenino con 64.6% y se obtuvieron como conclusiones:

“se tuvo una percepción moderada en más de la mitad de los adultos y una alta percepción de riesgo en casi la tercera parte. Los adultos mexicanos tienen una percepción moderada del riesgo de Diabetes Tipo 2.”

Dannya de la Vega y Natalia Ramirez Girón (33) realizan una investigación en el presente año, titulada “Percepción y conocimiento de Diabetes tipo 2 y riesgo de diabetes en adultos”, una investigación cualitativa descriptiva correlacional, donde participaron 182 personas. Se obtuvo como conclusiones:

“El 78% de los participantes fueron mujeres con promedio de edad de 58.8 años, el 50,5% presenta una percepción de riesgo alta, teniendo relación positiva entre conocimiento y percepción de riesgo de la DT2”

López Escamilla J., et al. (34) en el 2024, México, realizaron una investigación titulada “Percepción de riesgo y riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en estudiantes mexicanos”, este estudio fue transversal analítico, se utilizó el instrumento de Percepción de riesgo de la DMT2 escala Likert con los 8 enunciados originales en las tres dimensiones de percepción de riesgo, en estudiantes entre 18 y 40 años, 67.3% de los participantes presenta sobrepeso/obesidad, y se concluye que:

“Los que perciben mayor riesgo, reportan mayor riesgo, la percepción de riesgo predominante es con una media de 18.6. Y según dimensiones, los varones presentan mayor control interno, los estudiantes de postgrado tienen mayor riesgo y mayor preocupación.”

De los antecedentes mencionados, es pertinente describir datos sociodemográficos para poder visualizar la percepción según el nivel educativo, edad y el haber tenido antecedentes familiares. Siendo esta última resaltado por Koipuram et al. (31) y Sulaimán et al. (32), ya que mencionaron que el tener antecedentes familiares implica el cuidado y por lo tanto el conocimiento empírico, en consecuencia, la percepción más alta, esto es afirmado por la investigación de Alzaben, Abeer S., et al. (34), ya que realizan programas teóricos y si bien elevaron los conocimientos y prácticas, la percepción se mantuvo igual antes y después de las intervenciones.

La presente investigación describe los resultados de la percepción de riesgo basándose en tres dimensiones, similares al de Angelina P. Nguyen (26), estas fueron probabilidad percibida, el riesgo personal, el riesgo general (Control personal interno y externo), riesgo cognitivo, emocional (preocupación) y optimismo poco realista (sesgo optimista), lo que afirma las particularidades y los factores que intervienen en la percepción. Antwi, Janet, et al. (24) resalta la importancia de medir el sesgo optimista, ya que en su población

participaron personas con presentes factores de riesgos metabólicos, sociodemográficos y antropométricos, sin embargo, obtuvieron niveles de percepción baja, lo cual afirma la relevancia de esta dimensión para determinar el nivel de percepción. Estudios recientes y de una población parecida al presente constructo, son el de Jimenez, Karla, et al., ya que dentro de su grupo etario se considera al de esta investigación. Por último, en el estudio de Dannya de la Vega y Natalia Girón, se utilizó el mismo instrumento de Percepción de riesgo de la DMT2, sin embargo, en el estudio actual se aumentaron enunciados para mejor comprensión de la población.

Por lo tanto, los antecedentes anteriormente descritos, son importantes para el presente constructo, ya que se entiende la relevancia de la variable y lo importante de estudiarla, ya que lleva consigo valoración subjetiva con fundamento no solo en lo adquirido teóricamente sino en base a la experiencia. Además, estudiarlo en la población adulta, con variedad de sexo y características individuales, aumenta la confiabilidad en la población estudiada, para siguientes investigaciones.

2.2. Bases teóricas

2.2.1. Diabetes Mellitus

La diabetes tipo 2 (DM2) es una de las enfermedades no transmisibles más comunes en Perú. Se caracteriza por una disfunción o alteración en las células beta del páncreas, influenciada por factores ambientales, genéticos y comportamentales, y está estrechamente relacionada con comorbilidades como la obesidad y la hipertensión. (35). Uno de los signos clínicos más relevantes de la diabetes tipo 2 es una glucemia en ayunas superior a 126 mg/dL, lo que generalmente indica la presencia de hiperglucemia sostenida. Esta condición es un factor clave en el desarrollo de la resistencia a la insulina, un trastorno metabólico que suele preceder al diagnóstico formal de diabetes. (36).

A. Fisiopatología: El páncreas es un órgano con funciones tanto endocrinas como exocrinas, produciendo hormonas y enzimas digestivas. Dentro de su función endocrina, las células alfa y beta desempeñan roles cruciales: las células alfa secretan glucagón, que aumenta los niveles de glucosa en sangre, mientras que las células beta producen insulina, que disminuye esos niveles. La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad crónica caracterizada por una disminución progresiva de la función de las células beta del páncreas. Esta alteración, conocida como resistencia a la insulina, es causada por niveles elevados de glucosa en sangre, que pueden resultar de un consumo excesivo de alimentos ricos en glucosa y de un bajo gasto energético, aunque la enfermedad tiene múltiples factores causales. Para diagnosticar la DM2, se realizan pruebas de glucosa en sangre en ayunas y se mide el nivel de hemoglobina glicosilada. El manejo de la enfermedad puede incluir el uso de medicamentos como la metformina o insulina inyectable, dependiendo del estado del paciente. Es fundamental monitorear la adherencia al tratamiento, ya que una buena adherencia

puede prevenir o retrasar las complicaciones sistémicas asociadas con la diabetes. (37) (38).

B. Factores de riesgo: Los factores de riesgo son situaciones o características que alteran el equilibrio del individuo, predisponiendo a una mayor probabilidad de padecer una enfermedad (39). Entre los factores de riesgo existen clasificaciones según los determinantes sociales y dos subdivisiones de acuerdo con la posibilidad de modificarlo o no, esta última siendo de interés ya que especifica en qué factores pueden intervenir el individuo, familia, comunidad y los profesionales de la salud para una adecuada atención primaria.

C.1. Factores no modificables

Edad: Esta enfermedad generalmente se desarrolla en adultos maduros (40 a 60 años) (40) (41) aunque no se descarta el riesgo en adultos mayores ya que el organismo envejece y las comorbilidades predisponen a la persona a que la enfermedad se desarrolle. Heredia y Gallegos (42) determinan que existe una relación entre el riesgo de adquirir diabetes y la edad, es decir a más edad, mayor riesgo de tener DM2 afirmando una relación directamente proporcional, así mismo describieron la relación indirecta entre el riesgo y el nivel de instrucción de los individuos.

Según la Federación Internacional de Diabetes 135, 6 millones de personas (19,3%) hasta el 2019 de entre 65 y 99 años tenían diabetes y se estima que serán 195,2 millones en 2030 y de 276,2 millones en 2045 en ese grupo etario (43).

Raza/Etnia: Los estudios revelan que las personas de raza blanca o caucásica tienen menor posibilidad a desarrollar la enfermedad que los de asiáticos,

negros e hispanos, así como nativos americanos (44). Sin embargo, esta clasificación puede ser en parte influenciada por factores modificables, pues Bancks M. et al. (45) en un estudio en Estados Unidos, determina las asociaciones de factores biológicos, socioeconómicos, de vecindario y conductuales modificables en la edad adulta joven con la disparidad racial observada en la incidencia de diabetes entre individuos negros y blancos de mediana edad, se halló que si bien los individuos negros tenían más probabilidades de desarrollar DM2, esta dejó de ser significativa si se ajustaban los factores modificables de ambos grupos raciales.

Antecedentes: Los individuos que tienen familiares de primer grado con DM2 tienen de 2 a 3 veces más riesgo de tener DM, así mismo aquellos que tienen padres o madres con DM2 tienen 5 a 6 veces más riesgo de tener DM2 (46) (47). Esta información está relacionada con la susceptibilidad genética pues existen 3568 asociaciones de DM2 con expresión génica predicha en 687 genes nuevos (48). Por otro lado, aquellas mujeres que tuvieron diabetes mellitus gestacional (DMG), tiene mayor riesgo no solo de presentar DMG en su próximo embarazo, sino de desarrollar DM2 si la hemoglobina glicosilada (A1C) es mayor igual a 6,5%, así mismo, cabe resaltar que este valor no es saludable tanto para la madre y feto, ya que la hiperglicemia en el primer trimestre de embarazo está asociado a aborto espontáneo, anomalías congénitas o complicaciones en esta etapa. (49) En México, Chávez et al. (50) entrevistó a 5 mujeres que tuvieron mayor percepción de riesgo, antecedentes de DMG e interés en el control de esta. Tuvo como resultados que la mayoría de las mujeres definió correctamente la DMG así mismo tuvieron conocimiento sobre los factores predisponentes, mencionando a la

alimentación, el sobrepeso y antecedentes de la enfermedad, de igual manera la percepción de riesgo por la presencia de DMG mencionaron el tener un hijo con sobrepeso, riesgo de desarrollar DM2 y DMG en embarazos futuros”

C.2. Factores modificables

Sobrepeso y Obesidad: Es la acumulación por encima de lo normal de tejido adiposo siendo perjudicial para la salud. Es de etiología multifactorial, de las cuales se resalta el estilo de vida y el desequilibrio de ingesta y gasto de energía (51). La alimentación es la ingesta de alimentos con la finalidad de satisfacer necesidades fisiológicas con los nutrientes que estos aportan. Sin embargo, existen alimentos que se deben consumir de manera limitada por los deficientes nutrientes o los excesivos macronutrientes que aportan, pudiendo desencadenar un desequilibrio energético en relación con el gasto que tenga el individuo, desencadenando sobrepeso u obesidad. El IMC es un indicador importante que determina el peso adecuado según la estatura del individuo, Teufel et al. (52) afirman que “se observó un mayor riesgo de DM2 con un IMC mayor igual de 23 kg/m² , con un 43 % más de riesgo de diabetes para los hombres y un 41 % más de riesgo para las mujeres en comparación con un IMC entre 18,5 - 22,9 kg/m²” (53) Para ello se debe tener en cuenta que los refrescos o bebidas con azúcar se asocia a la obesidad infantil, lo cual está estrechamente relacionada a un desarrollo de la DM2 en la edad adulta (54), y un incremento de peso en adulto; por lo contrario, una dieta rica en fibra, verduras, granos, lácteos bajos en grasas y aceites como el de oliva o girasol, están asociados a un menor riesgo de desarrollar DM2 (47).

Hábitos de alimentación: El consumo de nutrientes es fundamental para un adecuado funcionamiento del organismo, además ayuda a conservar la salud y prevenir enfermedades por malnutrición. Una alimentación no balanceada pone al individuo en riesgo de tener ENT como la diabetes mellitus tipo 2 (55) (56). Estudios demuestran que los conocimientos y hábitos de alimentación saludable intervienen desde los primeros años de vida favoreciendo un desarrollo y crecimiento adecuado, además de prevenir el sobrepeso y la obesidad por tener un consumo y gasto de energía acorde el estilo de vida individual (57) (58). El consumo diario de alimentos que se recomienda para una dieta saludable para un adulto es consumir azúcares libres (azúcares agregados en bebidas o alimentos, miel, etc.) en menos del 5% del consumo calórico total, consumir sal por debajo de los 5g, consumir como mínimo 400g de frutas y hortalizas, menos del 30% de ingesta calórica debe provenir de las grasas de las cuales se debe ser preferiblemente grasas no saturadas presentes en la palta, pescados, frutos secos etc., así mismo la Asociación Americana de Diabetes (ADA) recomienda un consumo diario de 20 a 35g de fibra, pues esta ayuda no solo a tener una mayor carga fecal sino a regular la glucosa en sangre mejorando la sensibilidad a la insulina en el organismo (59) (55). Estudios recomiendan llevar una dieta balanceada ya que este es indispensable para poner en riesgo la salud de la persona, pues cuando el consumo de azúcares es elevado, la concentración de glucosa en sangre daña a las células beta del páncreas productoras de insulina, lo que lleva a un signo de DM2 (60).

Actividad física: Realizar actividad física es recomendable en todos los niveles de prevención, ya que previene enfermedades, trae sensación de bienestar general y reduce complicaciones de las enfermedades (61). Específicamente la

relación de la realización de ejercicio y el riesgo de desarrollar DM2 es inversamente proporcional, ya que la actividad física disminuye glucosa en sangre, controla el peso y se asocia a equilibrio en el perfil lipídico en sangre (47) (62). Además que en estudios de España y Chile se afirma que el sedentarismo es un factor de riesgo importante (63) (40), pues personas con el mayor tiempo sentado y con obesidad tienen 3, 1 veces más riesgo de tener DM2 que personas con niveles bajos de tiempo sentado y un IMC normal (64). El tejido adiposo visceral es una característica del sobrepeso y obesidad, por lo que el perímetro abdominal superior de los 102 cm y 88 cm en varones y mujeres respectivamente no solo estaría relacionado con enfermedades cardiovasculares (65) sino también con una resistencia a la insulina, pues el exceso de ácidos grasos no esterificados, estimulado fundamentalmente por tejido adiposo abdominal, conduciría a una resistencia a la insulina (66) (67).

Hábito de Fumar: El hábito de fumar es la principal causa prevenible de enfermedades y de muerte, el dejar este hábito antes de los 50 años reduce a un 50% el riesgo de morir en los siguientes 15 años (68). Los fumadores se predisponen a tener valores elevados de glucosa en sangre, resistencia a la insulina y estar altamente relacionado con las complicaciones de la DM2 una vez tenga el diagnóstico (69).

2.2.2. Percepción de Riesgo

La percepción es el primer paso para el proceso cognitivo, es el conjunto de recepción e interpretación de cualquier estímulo que proviene de los sentidos, de tal manera que para cada individuo es diferente la identificación de cada fase. La recepción, se basa en cómo lo reconoce o distingue, la fase de interpretación se ve influenciada por conocimientos previos, contexto y emociones, es decir, cada individuo le dará su significación (14) (15). Según la psicología de la Gestalt, la percepción, es la base de la actividad mental tales como la memoria, aprendizaje, pensamiento, etc., pues estas dependen de la organización perceptual (70).

La existencia de una percepción sobre la salud depende del grupo etario, presencia de enfermedades y calidad de vida. Razo et al. (71) afirma que las personas en la edad adulta mayor con enfermedades tienen una inadecuada percepción de salud además de una calidad de vida deficiente, en comparación con jóvenes sin enfermedades y una mejor calidad de vida.

La percepción de riesgo es una visión subjetiva de la vulnerabilidad de la salud frente a una enfermedad. Según las investigaciones si bien la percepción de riesgo percibido en la salud es subjetiva, derivan de un riesgo objetivo. Josianne Kollmann et. al. (72) realizaron una investigación con el objetivo de hallar una relación entre experiencia de riesgo y la percepción de riesgo, ya sea en riesgos agudos como ataques terroristas y riesgos de salud o acumulativos, como el consumo de alcohol, tabaco y alimentación poco saludable, en Israel y Alemania. Se obtuvo como resultados que se tiene una alta percepción de riesgo personal y social cuando hay una experiencia de terrorismo, sin embargo, la experiencia personal con riesgo acumulativo para la salud tiene relación con percepción de riesgo personal.

La asociación entre experiencias importantes, como crisis, accidentes, enfermedades, violencia y percepción de riesgo sirve para definir riesgos como los desastres naturales, delitos violentos, enfermedades, etc., por ello es importante tomar en cuenta a la percepción de riesgo percibido como un indicador para que el área de salud preventiva pueda buscar maneras óptimas de intervención, sin dejar de lado que existen factores que la influyen, como edad, género y educación en el tipo de percepción de riesgo que se desea estudiar (73).

A. Primer modelo de Percepción de Riesgo como indicador

Entre los primeros estudios que toman a la percepción de riesgo como indicador directo del riesgo de la persona y la influencia en las actitudes y comportamientos frente a la problemática, fue la investigación de Sander Van Der Linden.

La escala de Percepción de Riesgo del Cambio Climático (PRCC) se ha asociado con la predisposición de las personas a involucrarse en acciones que posibiliten la mejora favorable del cambio climático, apoyando políticas públicas con el mismo objetivo.

Van Der Linder en el 2014 (74) aplicó un instrumento compuesto por 8 ítems, una escala de Likert con 7 opciones dirigido a 808 sujetos de Reino Unido con el fin de explorar la relación causal entre la experiencia personal con eventos climáticos extremos, el afecto negativo y las percepciones de riesgo del cambio climático, donde se encontraron correlaciones significativas que indican que el efecto de la experiencia personal con eventos climáticos extremos está totalmente relacionado con la percepción de riesgo, en este estudio se concluyó, que la PRCC tiene como factores que explican alrededor del 70% variación significativa, a las experiencias, socioculturales y cognitivas.

Esta investigación dio paso a muchos autores a medir la percepción de riesgo y correlacionar con creencias, normas subjetivas y conductas en diferentes lugares del mundo (75), no dejando de lado al Perú en esta iniciativa (76). Tal es así que se le dio importancia a medir la percepción de riesgo no solo del medio ambiente sino de la salud, ya sea para medir percepción de riesgo de enfermedades infectocontagiosas o no transmisibles (77).

B. Modelos de percepción de riesgo para enfermedades no transmisibles (ENT)

Para poder medir la percepción de riesgo, se utilizan instrumentos tales como cuestionarios según indicadores, entrevistas y enunciados en primera persona con opción múltiple según escala de Likert. En el presente año, Molla Shumye (78) realizó un estudio transversal para relacionar y analizar la percepción de riesgo, el conocimiento y la intención de adoptar conductas preventivas para las enfermedades no transmisibles. Los resultados de esta investigación dan a conocer que la percepción alta de riesgo y una alta intención eran las principales características para adoptar medidas preventivas. La percepción de riesgo baja, reflejó un optimismo en la salud lo que facilita adoptar medidas de cambio.

En otro estudio (79) para medir la percepción de riesgo de Diabetes y enfermedades cardiovasculares, se tomó en cuenta factores de riesgo y percepción de factores de riesgo. Para determinar la relación se hizo un seguimiento de 5 años donde se obtuvieron datos como el IM y nivel de glucosa en sangre. El análisis consistió en determinar que las personas con IMC y glucosa en sangre elevados percibían riesgo en el futuro y predice cambios de estilo de vida para enfermedades crónicas, por lo que es de ayuda para que los entes de la salud busquen la manera óptima para intervenir en los comportamientos frente a enfermedades crónicas.

2.2.3. PERCEPCIÓN DE RIESGO PARA LA DIABETES MELLITUS TIPO 2

A. Percepción de riesgo sobre los factores de riesgo de la DM2

En el estudio de Janett Antwi (21) se utiliza un instrumento que mide la percepción de riesgo de los factores de riesgo de la DM2, tomando en cuenta la división de factores de riesgo modificables y no modificables. Generalmente para evaluar las percepciones de riesgo se utiliza encuesta de Percepción de Riesgo Diabetes mellitus una escala de Likert modificada con enunciados afirmativos en primera persona. Los factores no modificables tienen relevancia por su comparación de la percepción de riesgo con datos demográficos y riesgos reales de la persona tales como antecedentes, edad, sexo y nivel educativo, que se hallan antes de responder el instrumento propiamente dicho.

B. Percepción de riesgo sobre complicaciones de la DM2

Una de las escalas que pueden ser utilizadas para determinar la percepción de riesgo de personas con la enfermedad, es la Escala de percepción de riesgo de agravamiento de la enfermedad, instrumento que mide los posibles motivos de agravamiento, el resultado grave, control de comportamientos y experiencia afectiva o emocional. Esta escala está compuesta por 40 ítems medida en Likert de 5 puntos (80).

La encuesta de Percepción de Riesgo Diabetes mellitus es utilizada no solo para determinar la PR de la enfermedad sino de las complicaciones, tal es así que Saglam y Bektas (81) se realizó un estudio a 330 pacientes con DM2 en el Hospital de la ciudad Eskisehir y se utilizó una Escala de Evaluación del Tratamiento de Insulina y la Encuesta de Percepción de Riesgo Diabetes Mellitus. Las conclusiones de este estudio dieron a conocer una percepción negativa alta de complicaciones en insulino dependientes en comparación de otros diabéticos que reciben tratamiento con otros medicamentos.

C. Percepción de riesgo del desarrollo de la DM2

La percepción de riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 es un indicador necesario ya que se relaciona directamente con los comportamientos para reducir el riesgo (23), además que estudios revelan que la percepción de riesgo refleja indicadores reales de riesgo. El instrumento más usado es la Encuesta de Percepción de Riesgo para el Desarrollo de Diabetes (RPS-DD) (26).

Para medir a esta variable existen dimensiones, entre ellas están identificadas a la probabilidad percibida, riesgo personal (control personal interno y externo), riesgo general, riesgo cognitivo, emocional (preocupación), comparativo y el sesgo optimista. Para el presente constructo se tomará en cuenta 4 factores medidas en 3 dimensiones.

C.1. Dimensiones e indicadores

- **Control personal interno y externo:** Diversos estudios en salud mental definen que el control personal refiere a las creencias que tiene el individuo sobre el desarrollo de una labor, alteración psicoemocional o enfermedades físicas, es decir si está en sus manos (control interno) o si está bajo control de las personas del exterior (control externo) (82) (83) , estos dos factores con dirección diferente, en el presente estudio están en la misma dimensión para determinar la percepción de quién o quiénes tienen el control del desarrollo de la enfermedad (DM2) en ellos mismos. Tal premisa se puede demostrar en que estudios anteriores se resalta que los hábitos alimentarios son los más percibidos, pues las personas relacionan y perciben que el comer ciertos alimentos en cantidades desproporcionadas, así como no realizar actividades físicas acorde a su edad y estilo de vida, está directamente relacionado a desarrollar alguna enfermedad como la diabetes mellitus y que es la responsabilidad

de cada uno (control interno), investigaciones afirman que las personas que creen tener un mayor control interno sobre su salud tienden a percibir un menor riesgo, eso sustenta el por qué en esta dimensión los puntajes están de manera inversa. (53) (54) (56) Por otro lado, existen ciudadanos y poblaciones que responsabilizan el control de su salud al acceso de servicios de salud, a médicos o enfermeras y a la información que se les brinda o que adquieren de fuentes confiables, por lo que a pesar de que perciben el riesgo, su percepción de control externo es mayor que al interno, teniéndose un punto de análisis y valoración particular. Estudios como el de Khan Raihan, et al. (20), nos demuestra que aquellos que tienen más conocimientos, que pueden percibirlo como control interno o externo, se perciben con menos riesgo, así mismo definen sus probabilidades de riesgo en un futuro, por lo que es importante esta dimensión en el análisis de la percepción para entender actitudes futuras que puedan tomar las personas.

- **Preocupación:** En el ámbito de la salud, esta es una característica emocional frente a la posibilidad de desarrollar o no una enfermedad, es decir emoción frente a situaciones inciertas sobre la salud y bienestar físico, su presencia interfiere en las intenciones de adquirir conocimiento, ya que esta dimensión perceptual permite interiorizar subjetivamente la enfermedad, tal es así que Koipuram et al., destaca que en un grupo estudiado de personas, entre varones y mujeres, fueron en su mayoría las mujeres las que participaron en la administración de medicamentos y curación de heridas entre el manejo de otras complicaciones, lo cual dio como resultado que la percepción del desarrollo de la diabetes de las hijas era alta, aunque en realidad los varones tenían más factores de riesgo de desarrollar la enfermedad (28). De lo antes mencionado se infiere que las emociones involucradas tales como la preocupación, que tuvieron las hijas, es un indicador para adoptar medidas preventivas a partir de

la autoconcientización, ya que así se realicen las prácticas y se conozca, ello no impacta en la adaptación e implementación de actividades preventivas tanto como la percepción. Rymon y Nowicka tomaron en cuenta a este indicador en su estudio en pacientes con DM1 y afirman que quienes perciben beneficio de su enfermedad, tienen puntajes significativamente altos en control personal y control de tratamiento, mientras que tienen puntajes de percepción baja en preocupación (84).

- **Sesgo optimista:** Esta dimensión tiene la característica de determinar la percepción de un riesgo o no a desarrollar diabetes sin tener en cuenta el riesgo en sí mismo, es decir que se evidencia una actitud positiva o con pronóstico de bienestar subjetivo poco realista frente a otras personas, minimizando su percepción de riesgo personal en comparación con los otros. (27) Antwi Janet, et al. (21), tuvo como resultado en su investigación que menos de la tercera parte percibía riesgo de desarrollar la DM2, y que, de la mayoría de sus participantes con glucemia alta en ayunas, tuvieron percepción baja. Es decir que, a pesar de los riesgos presentes, si ellos no lo perciben, dichos riesgos son inexistentes. En el instrumento utilizado para medir la percepción de riesgo, se tienen 2 indicadores para evaluar el sesgo optimista, que según la literatura (85) a mayor puntaje, mayor sesgo optimista, por lo tanto, se entiende que cuando las personas subestiman su riesgo, suelen considerarse menos vulnerables en comparación con otras personas, lo que lleva a que se necesite una inversión de los puntajes para que sean coherentes con la percepción de riesgo real. (23)

2.2.4. Rol de Enfermería

A. Enfermería y percepción de riesgo de la DM2

Los patrones funcionales de Marjory Gordon, son fundamentales para poder desarrollar actividades o intervenciones en enfermería, ya que denota interés

holístico en la persona o familia, por lo que utilizar esta herramienta para el cuidado, evidencia una práctica aplicada en evidencia científica para determinar necesidades fisiológicas y psicológicas del paciente (86).

Es por ello por lo que Marjory Gordon en su primer patrón Percepción y manejo de la salud, que se toma en la etapa de valoración, busca determinar el concepto o idea que tiene el paciente respecto a su salud en general, ya sea bienestar y enfermedad en ella (12).

La percepción de riesgo de la salud es la primera impresión en base a conocimientos e ideas previas sobre los factores de riesgo de una determinada enfermedad, esta puede determinar la participación o intervención de las personas en acciones o medidas preventivas para su propio estilo de vida (85).

B. Enfermería en la prevención de DM2

Las medidas preventivas son aquellas acciones que se toman para retrasar, disminuir o eliminar el riesgo de adquirir o desarrollar una enfermedad, modificando el estilo de vida, alimentación y hábitos del individuo, ya que estas son parte de los factores que pueden modificarse y controlar con un adecuado conocimiento y prácticas (87).

De manera fisiológica existe una elevación de glucosa en sangre a causa de las emociones fuertes ya sea por estrés, ansiedad o depresión, pues el cuerpo se prepara para enfrentar las situaciones, deja de producir insulina para proteger y ayudar a enfrentar estas situaciones, por lo que una mirada holística de prevención es fundamental, tomando en cuenta no solo aspectos físicos para prevenir sino psicoemocionales (88) (89). Este tema es de importancia para el peruano, ya que la incidencia y prevalencia de la DM2 está en incremento, tomándose en cuenta los factores de riesgo relacionados, el más alarmante es el estado de sobrepeso y obesidad en más de la mitad de adulto y un cuarto de población infantil, por lo que

se necesitaría atención de profesionales en los niveles de prevención según la situación de la persona familia y comunidad (90).

A pesar de la incidencia y prevalencia de esta enfermedad, no se tiene una adecuada medida preventiva en ninguno de los 3 niveles de prevención, de tal manera que pone en riesgo la calidad de vida del paciente (91).

Como profesionales de enfermería se apela a la Teoría del déficit de autocuidado de Dorothea Orem, donde se define autocuidado a las capacidades que el individuo tiene para cuidar de sí en su total integridad, de tal manera que mantenga su salud en equilibrio, pues esta se puede ver alterada por factores externos (económicos, socioculturales o ambientales) o internos (emocionales, alteraciones psicológicas o predisposiciones biológicas) que pondrá al individuo en una posición de necesidad del cuidado del profesional de enfermería. Esta teoría se puede aplicar para cualquier nivel de prevención, solo se debe determinar de manera apropiada el grado de autocuidado de la persona, es así que el profesional de enfermería aplicaría actividades de enseñanza, consejerías, cuidado en necesidades básicas, aplicaciones de tratamientos, entre otros (92).

C. Enfermería en la promoción de la salud

El Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender es utilizado en el área de Enfermería para comprender los comportamientos de las personas respecto a la salud y tiene como finalidad promover actividades, para poder alcanzar prácticas saludables que mejoren la salud y bienestar de las personas, familias y comunidad, así mismo prevenir enfermedades, de tal manera que ellos tengan el control sobre sí mismos y se eliminen los riesgos que predisponen a diversas afecciones (93)

Para poder aplicar este modelo, diversos estudios e investigaciones realizan un plan de cuidado, capacitación, planes de intervención, etc., de tal manera que se observe

y analice los resultados para contrastar el avance o diferencia de los métodos de intervención de enfermería con este modelo. (94) (95).

En torno a lo mencionado, este modelo es infaltable en los planes de acción en el área de enfermería por lo que el objetivo es que las personas tengan el poder y la capacidad de aplicar métodos aptos para cada contexto y entorno socio – ambiental.

2.3. Definición operacional de términos

- Percepción de riesgo: Impresión subjetiva de un estímulo predisponente a un desequilibrio en la salud del individuo que se interpreta en base a conocimientos previos, ideas, pensamientos, etc.
- Adulto: En el Perú una persona se considera adulto cuando está dentro del rango de edad de 30 años hasta los 59 años 11 meses y 29 días.

III. HIPOTESIS Y VARIABLES

3.1. Variable

La Percepción de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2, es una variable de naturaleza cualitativa que en la investigación asumirá una posición cuantitativa, ya que será medido a través de tres dimensiones por una encuesta en escala de Likert, con un valor final de percepción baja, media o alta.

IV. MATERIAL Y MÉTODOS

4.1. Tipo de estudio y método de investigación

Investigación de naturaleza cuantitativa descriptiva (96), ya que la variable se midió a través de una escala de Likert modificada y se describió lo hallado a través del instrumento, de donde se observó los niveles de percepción en la población de manera prospectiva.

4.2. Diseño de investigación

La investigación es de tipo no experimental de corte transversal (96), ya que los datos se recogerán en un tiempo determinado que será 30 días entre julio y agosto del 2024.

4.3. Sede de Estudio

El distrito de San Juan de Lurigancho es actualmente considerado el distrito de Cono este más poblado del Perú con 1 millón 225 mil 92 habitantes en el 2022. La superficie total del distrito es de 131,25 km², lo cual hace que la densidad poblacional sea de 9mil 340 habitantes/km².

Entre las causas de morbilidad de la población están principalmente: las infecciones de vías respiratorias agudas (35,6%). Caries dental (20,2%) y Obesidad u otros tipos de hiperalimentación (10,1%). Las enfermedades reportadas que permiten evidenciar las causas de mortalidad en la población hasta el 2016, son el un 97,35% por enfermedades no transmisibles, entre las principales se encuentra: IRA, Enfermedad Intersticial y Diabetes Mellitus; mientras que solo 2,65% por enfermedades transmisibles (TBC) (97)

Este distrito cuenta con 23 Centros de Salud y 10 Puestos de Salud del MINSA. El Centro de Salud Zárate es un establecimiento de salud I-3 ubicado en el cruce de Jr. Los Chasquis con Jr. Yupanqui en la Urb. Zárate. Corresponde a la DISA Lima Centro,

que ofrece como cartera de servicios a los siguientes: Odontología, Medicina general, Obstetricia, Enfermería, Psicología, Nutrición, Laboratorio, Farmacia, Estrategia sanitaria de TBC y Adulto mayor. Tiene como objetivo respaldar la integridad de la persona, previniendo enfermedades y favoreciendo la salud, llevando a cabo cada actividad con respeto a la vida y a los derechos humanos en todo el trayecto de vida de la persona, familia y comunidad.

Misión: Lograr que la población asignada a la jurisdicción tenga acceso a los servicios de Salud de Calidad, promocionando la salud, previniendo daños, restableciendo y rehabilitando, apoyando a las familias y articulando a las comunidades e instituciones afines, en la construcción de un entorno saludable.

Visión: En el año 2028 las familias de nuestra jurisdicción estarán sanas, satisfechas recibiendo una atención de calidad de sus amigos servidores de nuestro establecimiento, quienes realizan actividades con la comunidad, logrando entornos saludables y el desarrollo social de la población.

4.4. Población, muestra y muestreo

La población estuvo conformada por los usuarios y/o pacientes que se atienden en los consultorios del servicio de Medicina general, entre el rango de edad de 30 a 59 años. Tomando en consideración la atención promedio mensual, según el área de Estadística, en ese rango de edad, se estima que en los consultorios de Medicina general se atienden alrededor de 1200 adultos mensualmente, siendo este el número de población del presente constructo para obtener como muestra mínima a 292 personas según la fórmula de población finita. (Anexo 1)

4.4.1. Criterios de Inclusión

- Personas que acepten participar por medio del consentimiento informado.
- Personas que se atienden en los consultorios de Medicina General del Centro de Salud Zárate entre julio y agosto del 2024.
- Personas entre 30 y 59 años.
- Personas con capacidad de leer y escribir.
- Personas con pleno estado de salud mental.

4.4.2. Criterio de Exclusión

- Personas con discapacidad de ver y oír.
- Personas con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2.

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La técnica que se aplicó fue la encuesta y como instrumento una escala modificada. Inicialmente la escala Percepción de Riesgo para desarrollar Diabetes (RPS.DD) contaba con 8 enunciados (29), sin embargo, fue extendida para mejor entendimiento de la población, por lo que en la presente investigación se consideró necesario que esté constituido por 17 enunciados sin alterar las tres dimensiones ni indicadores, teniéndose como dimensiones sesgo optimista (2 enunciados), el control interno (7 enunciados) y control externo (5 enunciados), y preocupación (3 enunciados). La escala de Likert modificada se medirá con la puntuación 1 (muy en desacuerdo), al 4 (Totalmente de acuerdo), excepto con los enunciados de control interno, pues estos estarán codificados de manera inversa. Los valores más altos en la encuesta darán a conocer más control personal, más preocupación y sesgo optimista, por ende, mayor percepción.

Según la regla de máximos y mínimos, el instrumento tendrá una puntuación según

el número de ítems y los valores de cada uno de ellos, siento así que el número de ítems es 20, la Escala Likert mínima será igual 1 punto y el máximo 4 puntos. Los puntajes de valores finales por niveles sería que en percepción de riesgo bajo serán los que tienen entre 17 a 34 puntos, los de percepción de riesgo medio o moderado entre 35 a 51 puntos y los de percepción de riesgo alto entre 52 a 68 puntos.

La escala modificada fue validada por 3 jueces expertos por medio de un juicio de expertos, que evaluaron el criterio de claridad, con un puntaje de 0.8, lo que significa que los ítems son claros y en el criterio de relevancia 0.9, que indica que los ítems son pertinentes para lo que se desea evaluar. La confiabilidad se determinó a partir de los datos de la prueba piloto aplicando el coeficiente de alfa de Cronbach, para medir la correlación de los enunciados entre sí, teniendo 0,8 lo cual quiere decir que el instrumento tiene buena consistencia interna (96) (98).

4.6. Procedimientos de recolección de datos

Se solicitó una resolución de aprobación del proyecto, luego se contó con la aprobación del Comité de ética de la Facultad de Medicina.

La Escuela profesional de Enfermería, emitió cartas de permisos a nombre de la directora de la DIRIS LIMA CENTRO y a nombre de la Médico jefe del Centro de Salud Zárate para poder aplicar el instrumento aprobado.

Para poder acceder a la población, se solicitó a la DIRIS LIMA CENTRO con los documentos correspondientes, un permiso para acceder y aplicar el instrumento en el C.S. Zárate y posteriormente se presentó una solicitud al Centro de Salud Zárate, por medio del Médico Jefe del establecimiento.

Se aplicó el instrumento entre los meses de julio y agosto del 2024 a 320 personas, de las cuales realizando la depuración se tuvo en cuenta 300 encuestas llenadas correctamente a las personas que aceptaron voluntariamente a participar, que se atiendan en el centro de salud y cumplan con los criterios de inclusión.

Puesto que el instrumento se brindó a cada persona en forma física, los datos se procesaron de manera manual, según el libro de códigos del instrumento.

Una vez obtenido los puntajes directos de cada individuo, fue transformado en una base de datos, utilizando el programa Excel, para su posterior análisis en el programa SPSS.

4.7. Análisis estadístico

Se realizó el análisis estadístico descriptivo y con el objetivo de proporcionar una comprensión clara de la información con los datos recopilados, cálculos los estadígrafos como las medidas de tendencia central (media o mediana) según la distribución de los datos (análisis de la distribución). Además, se evaluó los niveles

de percepción de riesgo y de proporción, por cada dimensión de riesgo y de forma global; teniendo en cuenta los niveles correspondientes como son: percepción de riesgo bajo, percepción de riesgo medio y percepción de riesgo alto.

Los resultados obtenidos son presentados mediante tablas y cuadros, que permiten observar de manera clara y ordenada los análisis estadísticos y los niveles de percepción de la población de estudio.

4.8. Consideraciones éticas

Se elaboró consentimiento informado, un instrumento o proceso de comunicación que protege y resguarda el derecho y principio bioético de la autonomía, asegurando la dignidad de la persona investigada y total claridad de lo que esta implica (99), pues se presenta el título de la investigación del cuál será partícipe cada paciente o usuario del centro de salud, así mismo se da a conocer la cantidad de enunciados y el tiempo que podría tomarse en contestar todos ellos. Es importante mencionar el objetivo por el cual se realiza el estudio y la participación voluntaria, lo cual resalta el derecho a la libre decisión y opción a no participar si así lo desea (99). Finalmente se brinda el principio de confidencialidad, que guarda y respeta las opiniones, datos personales y resultado final del instrumento de cada individuo que acepta la participación en el presente constructo.

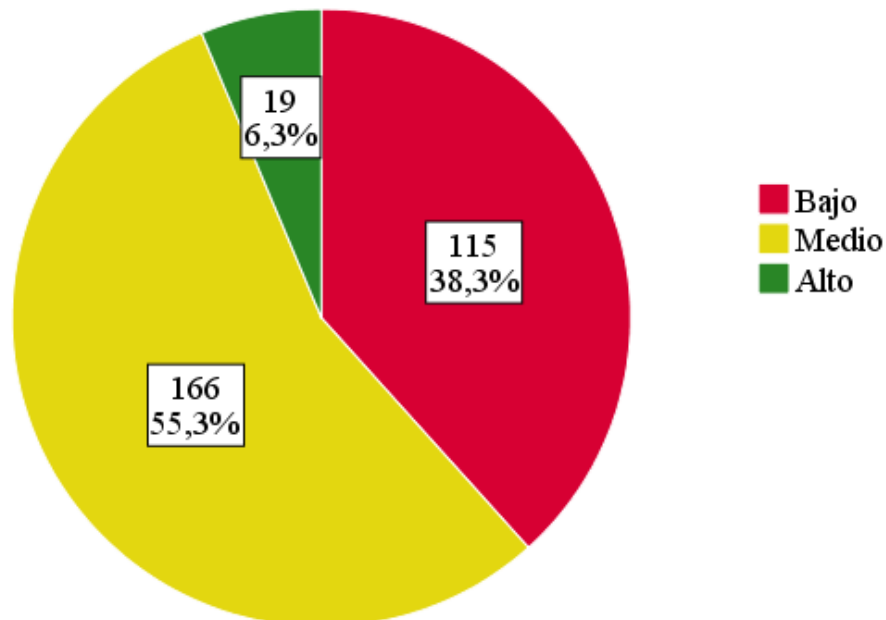
V. RESULTADOS

5.1. Datos generales

De las 300 de personas encuestadas se obtuvo que el 65,7% (197) de los participantes fueron del sexo femenino, siendo la media de edad 42 años. Predominó el grado secundario en la categoría de instrucción alcanzado con el 40% (120) seguido de superior técnica con 34,3 % (103), superior universitaria 19% (57) y nivel primario 6,7% (20). El 42,7% afirmó que tiene antecedentes familiares. En cuanto a presencia de alguna enfermedad o alteración física se obtuvo que el 40,7% (122) afirmó no tener ninguna enfermedad diagnosticada, el 32,3% (97) tiene sobrepeso, el 12% obesidad, el 11,7% (35) hipertensión arterial y el 3,3% (10) otra enfermedad como el hipotiroidismo. (ver ANEXO H)

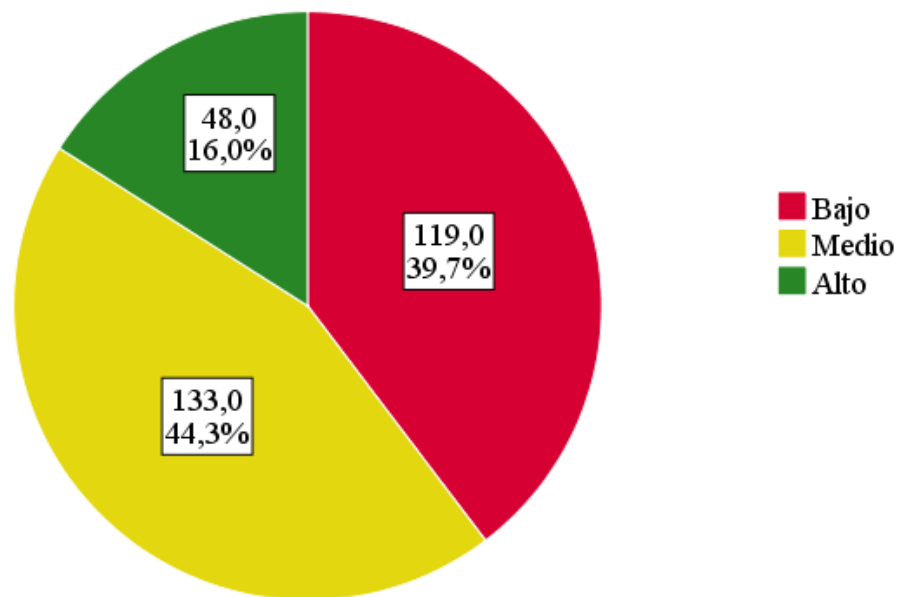
5.2. Datos específicos

Gráfico 1. Percepción de Riesgo de la diabetes mellitus tipo 2 en adultos que acuden a un Centro de Salud en San Juan de Lurigancho, 2024



En el gráfico 1 Percepción de Riesgo de la diabetes mellitus tipo 2 en adultos de un Centro de salud en San Juan de Lurigancho, 2024, se aprecia la percepción de riesgo de la diabetes, predomina el nivel de percepción de riesgo medio con 55,3%, seguido de percepción de riesgo baja con 38,3% y percepción de riesgo alto con el 6,3% de los participantes.

**Gráfico 2. Percepción de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2 en la dimensión
Sesgo optimista en adultos de un Centro de Salud en San Juan de
Lurigancho, 2024**



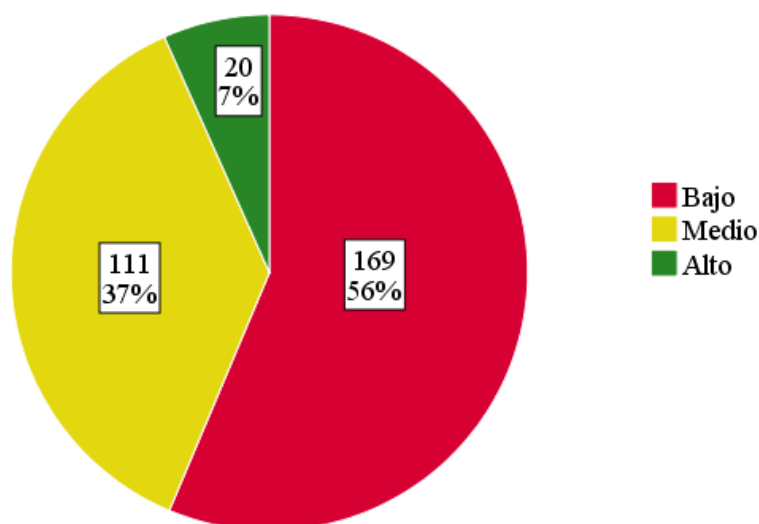
En el Gráfico 2 Percepción de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2 en la dimensión Sesgo optimista en adultos de un Centro de salud en San Juan de Lurigancho, 2024, se aprecia que, del total, 44,3% tiene el nivel de percepción medio, le sigue el nivel de percepción bajo con 39,7% y nivel de percepción alto con 16%.

Tabla 2. Indicadores de la percepción de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2 de la dimensión sesgo optimista, en adultos que acuden a un Centro de salud en San Juan de Lurigancho, 2024

Indicadores		Muy en desacuerdo		En desacuerdo		De acuerdo		Muy de acuerdo	
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	En comparación con otras personas que tienen mi edad y mi mismo sexo, tengo menos probabilidad que ellos en tener diabetes mellitus tipo 2.	49	16.3	99	33	106	35.3	46	15.3
2	En comparación con otras personas que tienen mi edad y mi mismo sexo, tengo menos probabilidad que ellos en desarrollar cualquier enfermedad grave o severa.	44	14.7	118	39.3	92	30.7	46	15.3

Para una mejor apreciación de cada dimensión se exponen los indicadores de cada una de ellas. En la tabla 2 Indicadores de la dimensión Sesgo optimista en adultos de un Centro de salud en San Juan de Lurigancho, 2024 se visualiza que la primera dimensión se mide a través de dos indicadores. El primer indicador revela si en comparación con otras personas de su edad y sexo sienten que tienen menos probabilidad en tener diabetes mellitus tipo 2, la respuesta predominante con 35,3% es “de acuerdo”. A diferencia del segundo indicador, que revela si en comparación con otras personas de su edad y sexo sienten que tienen menos probabilidad en desarrollar otras enfermedades, donde la respuesta mayoritaria con 39.3% fue “en desacuerdo”.

Gráfico 3. Percepción de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2 en la dimensión Control interno y externo en adultos que acuden a un Centro de salud en San Juan de Lurigancho entre los meses de julio y agosto, 2024



En el Gráfico 3 Percepción de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2 en adultos de un Centro de salud en San Juan de Lurigancho entre los meses de julio y agosto, 2024 en la dimensión Control interno y externo, se puede visualizar una diferencia con los gráficos anteriores, ya que, en esta dimensión, del total de participantes predomina el nivel de percepción bajo con 56% de personas y sigue el nivel de percepción medio con 37%. Este gráfico ilustra que más del 90% se encuentran en el nivel de percepción bajo y medio en la dimensión de control interno y externo.

Tabla 3. Indicadores de la percepción de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2 de la dimensión control interno y externo, en adultos que acuden a un Centro de salud en San Juan de Lurigancho, 2024

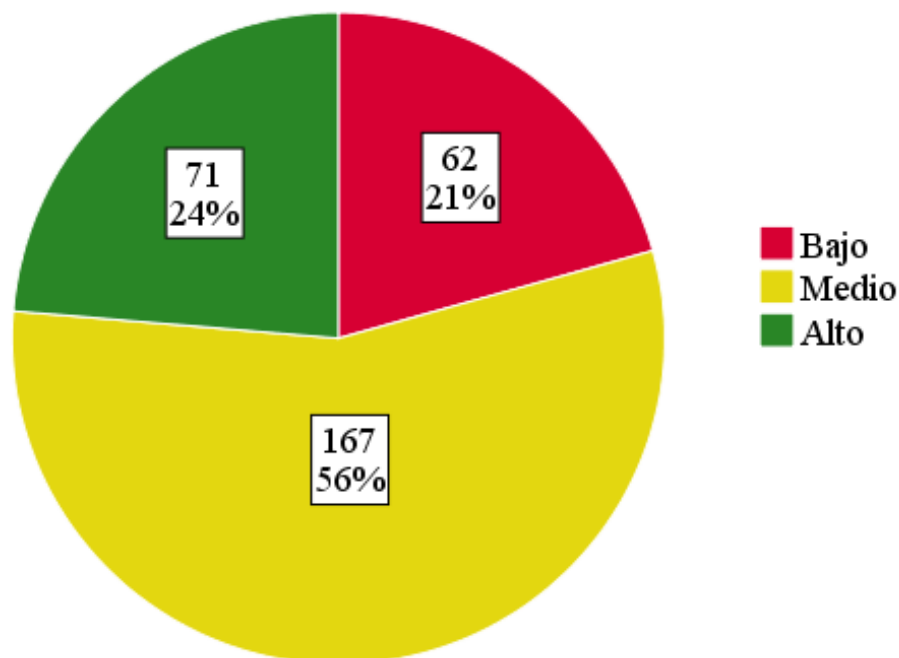
Indicadores		Muy en desacuerdo		En desacuerdo		De acuerdo		Muy de acuerdo	
		f	%	f	%	f	%	f	%
3	Creo que mis esfuerzos personales (como ir al médico o priorizar mi salud) me ayudarán a controlar/disminuir el riesgo que tengo de contraer diabetes tipo 2.	18	6.0	31	10.3	126	42.0	125	41.7
4	Creo que mis hábitos alimenticios (ejemplo: manera de preparar los alimentos, comer ciertos alimentos todos los días, beber agua, etc.) me ayudarán a controlar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.	23	7.7	30	10.0	118	39.3	129	43
5	Creo que mi estilo de vida (actividades que realizo todos los días o como rutina) me ayudará a controlar el riesgo de contraer diabetes mellitus tipo 2.	24	8.0	37	12.3	125	41.7	114	38
6	Creo que el nivel de actividad física que realizo (ejemplo: caminar, correr, bailar, etc.) me ayudará a controlar el riesgo de contraer diabetes mellitus tipo 2.	22	7.3	33	11.0	118	39.3	127	42.3
7	Las personas que hacen esfuerzo para controlar los riesgos de tener diabetes tipo 2, tienen menos probabilidades de tener diabetes tipo 2.	21	7	44	14.7	117	39.0	118	39.3
8	Las personas que tiene una alimentación balanceada (alimentarse según peso, edad, sexo y estilo de vida) tienen menos probabilidades de tener diabetes tipo 2.	23	7.7	31	10.3	126	42.0	120	40
9	Las personas que no tienen hábitos nocivos (ejemplo: fumar, tomar bebidas alcohólicas, etc.) tienen menos probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2.	32	10.7	59	19.7	107	35.7	102	34
10	Siento que tengo poco control sobre los riesgos para mi salud.	63	21	114	38.0	99	33.0	24	8
11	Siento que tengo poco control sobre el consumo de alimentos ricos en grasas y azúcar.	74	24.7	106	35.4	92	30.7	28	9.3
12	Siento que tengo poco control en las actividades que me mantienen en sedentarismo la mayor parte del día.	75	25	95	31.7	103	34.3	27	9
13	Si estoy destinado a tener diabetes tipo 2, no hay nada que pueda hacer al respecto.	120	40	122	40.7	39	13.0	19	6.3
14	Si me dicen que podría tener diabetes, no está en mis manos mejorar o mantener mi salud.	114	38	102	34.0	40	13.3	44	14.7

La tabla 3 Indicadores de la dimensión Control interno y externo en adultos de un Centro de salud en San Juan de Lurigancho, 2024, se aprecia que esta dimensión está compuesta por 7 indicadores para revelar el control interno (3 al 9) y 5 indicadores para el control externo (10 al 14).

Se puede visualizar que para el control interno, en los indicadores número 3, 5, 8 y 9, donde los enunciados afirman si ellos creen que sus esfuerzos personales y estilo de vida que tienen en el presente ayudan así como a las personas con alimentación balanceada a tener menos riesgo de tener diabetes tipo 2, la mayoría de participantes puso que está “de acuerdo”, afirmando los enunciados mencionados. Para los enunciados 4, 6 y 7, donde se afirma que sus hábitos alimentarios y actividad física que realizan los ayudarán a controlar el riesgo de tener diabetes tipo 2, donde la mayoría de los participantes puso que está “muy de acuerdo”.

Por otro lado, la subdimensión de control externo, para los enunciados 10, 11 y 13, donde se afirman si sienten que tienen poco control sobre los riesgos para su salud tales como consumir azúcares, alimentos ricos en grasa y si están destinados a tener diabetes, la mayoría está “en desacuerdo” con estos indicadores. Para el enunciado 14, la mayoría está “muy en desacuerdo” con el enunciado que hace referencia a que, si le dicen que podría tener diabetes, no está en sus manos mejorar o mantener mi salud. Pasa lo contrario con el enunciado 12, “Siento que tengo poco control en las actividades que me mantienen en sedentarismo la mayor parte del día.” Donde la mayoría está “de acuerdo”, afirmando que no pueden cambiar su estado sedentario durante el día o que no está en sus manos.

Gráfico 4. Percepción de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2 en la dimensión Preocupación en adultos que acuden un Centro de salud en San Juan de Lurigancho entre los meses de julio y agosto, 2024



En el Gráfico N°4 Percepción de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2 en adultos de un Centro de salud en San Juan de Lurigancho entre los meses de julio y agosto, 2024 en la dimensión Preocupación, se responde el tercer objetivo específico, se aprecia que del total de encuestados en la dimensión preocupación, predomina el nivel de percepción medio con 56%, le sigue el nivel de percepción alto con 24% y por último percepción baja con 21%.

Tabla 4. Indicadores de la percepción de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2 de la dimensión Preocupación, en adultos que acuden a un Centro de salud en San Juan de Lurigancho, 2024

Indicadores		Muy en desacuerdo		En desacuerdo		De acuerdo		Muy de acuerdo	
		f	%	f	%	f	%	f	%
15	Me preocupa tener o desarrollar diabetes mellitus.	55	18.3	46	15.3	131	43.7	68	22.7
16	Preocuparse por tener diabetes no nos da la solución, pero es necesario.	42	14	49	16.3	152	50.7	57	19
17	Preocuparse por tener diabetes mellitus es muy perturbador o incómodo.	50	16.7	51	17	140	46.7	59	19.7

En la tabla 4 Indicadores de la dimensión Preocupación en adultos de un Centro de salud en San Juan de Lurigancho, 2024, se visualiza que esta dimensión está compuesta por 3 indicadores, que afirman la preocupación para con la diabetes tipo 2 y si esta es necesaria. En los 3 indicadores, predomina la respuesta “de acuerdo”, afirmando que existe preocupación por el desarrollo de esta enfermedad.

VI. DISCUSIÓN

En el presente estudio realizado en adultos que acuden a un Centro de Salud de primer nivel de atención en el distrito San Juan de Lurigancho entre los meses julio y agosto del 2024, se encontró que los participantes presentan el nivel de percepción media. Este hallazgo sugiere que la mayoría de los encuestados está moderadamente consciente de la posibilidad de desarrollar diabetes tipo 2, aunque no de manera alarmante o extrema. No obstante, más de un tercio de la muestra percibe un riesgo bajo, lo que podría reflejar una predisposición a no adoptar medidas preventivas promocionales. (25)

El nivel de percepción de riesgo moderado observado en este estudio coincide con los hallazgos de López Escamilla et al. (36), donde también prevalece una percepción moderada, así como con la investigación de Jiménez et al. (34), quienes reportaron que el 59.3% de adultos mexicanos presentaban una percepción de riesgo similar. De manera similar, Khlaifat et al. (32) encontraron que en el 52.5% de los estudiantes evaluados mostraron una percepción media.

Sin embargo, estos resultados difieren de los estudios como el de Guo et al. (29) en China, donde el 90% de las participantes presentaban una baja percepción de riesgo. De igual manera, investigaciones realizadas en EE.UU. por Khan et al. (22) y Antwi et al. (23) reportaron una baja percepción del riesgo, a pesar de la presencia de factores predisponentes como antecedentes familiares y alteración de la glucosa en ayunas, respectivamente. En contraste, el estudio de Ramírez y De la Vega (35) encontró una predominancia de la percepción alta del riesgo, resaltando que es directamente proporcional a los conocimientos entre sus participantes.

Las diferencias en la percepción de riesgo observadas en los estudios pueden atribuirse a los diversos contextos en los que se llevaron a cabo, así como a las características de los participantes. En los estudios de Jimenez et. al (34) y Lopez Escamilla et. al (36) se examinan poblaciones de México, un país latino con costumbres y estilos de vida similar a los del Perú, lo que podría explicar la coincidencia en los hallazgos. Además, la muestra de estos estudios es comparable a la del presente trabajo, tanto en tamaño como en el rango de edad y la distribución por sexo. De manera similar el estudio de Khlaifat et al. (32) evaluó estudiantes universitarios con características similares a la muestra del presente constructo. Estos autores también observaron que los cuidadores de familiares con la enfermedad, presentaban una mayor percepción de riesgo.

Por otro lado, el estudio de Guo et. al. En China, aunque los participantes eran madres de edad similar, todas eran mujeres, que a pesar de tener antecedentes o familiares con diabetes tipo 2, no desempeñaban el rol de cuidadoras, lo cual es un aspecto clave. En contraste, en el presente estudio participaron personas de ambos sexos, de las cuales, hay quienes tienen antecedentes y son personas solteras, no son necesariamente padres o madres, por lo que podrían cumplir un rol de cuidador. Koipuram et al. (30) en su estudio resalta la diferencia de percepción de riesgo en varones y mujeres, afirmando que el rol de cuidador es un indicador fundamental para obtener un nivel de percepción media y alta.

En el estudio de Khan et al. (22) se observa predominantemente una baja percepción de riesgo, y en contraste, en el estudio de Ramirez y de la Vega (35) predomina percepción de riesgo alta, destacando en ambos estudios que el nivel de conocimientos y la percepción están directamente relacionados. Este hallazgo

podría relacionarse con el nivel educativo de los participantes en el presente estudio, donde la mayoría recibió la educación secundaria, aunque también hay una proporción visible con educación superior, y un porcentaje mínimo con solo educación primaria.

En la dimensión sesgo optimista, que mide la tendencia de los encuestados a creer que tienen menos probabilidad de desarrollar la diabetes tipo 2 o una enfermedad en comparación con otras personas de su mismo sexo y edad, predomina una percepción de riesgo media. Esto sugiere que las personas podrían estar subestimando su riesgo real.

En cuanto al indicador “*En comparación con otras personas que tienen mi edad y mi mismo sexo, tengo menos probabilidad que ellos en tener diabetes mellitus tipo 2*”, predominan los que están de acuerdo con esta afirmación, lo que refleja una percepción de menor riesgo en relación con sus pares. Esta percepción indica una subestimación del riesgo real, lo que podría llevar a comportamientos menos preventivos o cuidados inadecuados de la salud, ya que el individuo no se percibe en peligro o considera que su riesgo es menor al de los demás.

Por otro lado en el indicador “*En comparación con otras personas que tienen mi edad y mi mismo sexo, tengo menos probabilidad que ellos en desarrollar cualquier enfermedad grave o severa*”, predomina la respuesta “en desacuerdo”, lo que indica que perciben su riesgo de enfermar como igual o incluso mayor que el de las otras personas de su grupo de referencia. Esta visión más realista, o incluso pesimista sobre su riesgo podría motivar a tomar medidas preventivas o adoptar comportamientos más saludables, como hacer ejercicio, seguir una dieta equilibrada

o realizar chequeos médicos. Esta tendencia no se observa en el primer indicador, que se refiere específicamente a la diabetes tipo 2.

Estudios como el de Guo et. al. (29) revela que las madres que realizaban actividad física percibían menor riesgo, lo que explica un alto sesgo optimista. A pesar de que más del 50% de las madres tenían antecedentes familiares directos con diabetes tipo 2, no percibían el riesgo real. Este hallazgo, junto con los resultados de Nguyen et al. (25) y Antwi et al. (23) respaldan la idea de que la muestra del presente estudio podría estar subestimando su riesgo real.

La dimensión de control interno y externo evalúa las creencias de los encuestados sobre el grado en que el control personal (interno) o factores externos influyen en su riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Esta dimensión incluye creencias sobre el impacto de los hábitos personales, como la alimentación y el estilo de vida, así como la percepción de las personas sobre la capacidad de influir en su salud, o si lo atribuyen a factores fuera de su control. (56)

En esta dimensión la mayoría de los usuarios muestra una percepción de riesgo baja. Los indicadores de control interno destacan por las respuestas “*de acuerdo*” o “*muy de acuerdo*” lo que afirma que los participantes sienten que tienen el control sobre su salud. Esto, paradójicamente, está asociado con una baja percepción de riesgo, ya que quienes sienten tener el control tienden a subestimar su vulnerabilidad, lo que podría llevar a una menor predisposición para adoptar medidas preventivo-promocionales. (53) (54). Este resultado es consistente con estudios como el de Khan et al. (22), Guo et al., y en el de Antwi et. al. (23) donde se observó que los participantes no se sentían seguros de poder prevenir la enfermedad. Así mismo, aquellos que no tenían el hábito de hacer actividad física sentían menos control

sobre su propia salud. Por el contrario, el estudio de Lopez Escamilla (36) mostró que los universitarios, especialmente los varones tenían una alta percepción de riesgo en control interno, lo que los predisponen a adoptar medidas preventivas, conscientes de que la prevención de la enfermedad estaba en sus manos.

Respecto al control externo, predominan respuestas “*en desacuerdo*” o “*muy en desacuerdo*”, lo que indica que la mayoría no considera que el destino o la falta de poder personal determinen su riesgo de desarrollar la enfermedad. Estos resultados podrían indicar la posible necesidad de intervenciones educativas y de empoderamiento para que las personas se sientan más capaces de gestionar sus riesgos de manera activa. (22)

La dimensión de preocupación muestra una percepción moderada, lo que revela que más de la mitad de las personas experimentan algún nivel de inquietud respecto a la diabetes. No obstante, una parte significativa muestra una alta preocupación, lo que puede estar relacionado con experiencias personales o antecedentes familiares. (29) Esta preocupación puede actuar como un factor motivador para tomar medidas preventivas, aunque también parece generar cierta inquietud.

Por ello, la preocupación es un componente importante en la percepción de riesgo de diabetes, ya que es visto como un mecanismo de alerta (aunque no resuelva el problema en sí). En el contexto de los programas preventivos, sería ideal abordar esta inquietud de manera que motive a la acción sin generar un estrés emocional excesivo, que podría ser contraproducente.

Finalmente, este estudio destaca la necesidad de implementar intervenciones que mejoren la percepción de riesgo de la diabetes tipo 2 en la población. Es crucial

abordar el sesgo optimista, ya que subestimar el riesgo real puede llevar a un manejo inadecuado de la salud y a ignorar los verdaderos riesgos asociados. El hecho de que muchas personas no perciban control interno sobre su salud sugiere que se deben implementar estrategias educativas que fomenten el empoderamiento y la autodeterminación en la prevención y manejo de la diabetes. Además, la preocupación detectada puede ser utilizada como un catalizador para motivar la adopción de medidas preventivas más efectivas para cada individuo.

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. CONCLUSIONES

- En este estudio, la mayoría de los participantes perciben un riesgo moderado de desarrollar diabetes tipo 2, lo que indica cierta conciencia sobre la enfermedad, sin embargo, el porcentaje de personas con percepción baja es alarmante, tomando en cuenta que casi la mitad de los participantes tienen antecedentes familiares, un factor de riesgo no modificable.
- El nivel de percepción en la dimensión sesgo optimista es predominantemente nivel medio, lo que nos da a conocer la subestimación de la probabilidad de desarrollar diabetes de los colaboradores, por lo que se necesita mejorar conciencia sobre los factores de riesgo y fomentar autopercepción realista.
- El nivel de percepción en la dimensión de control interno y externo es en su mayoría baja percepción de riesgo, indicando que las personas sienten que los factores que determinan su riesgo escapan de su control, lo que puede interferir en el cambio de estilos de vida o acciones preventivas.
- El nivel de percepción en la dimensión preocupación es en más de la mitad de los participantes, nivel medio, lo cual está en desequilibrio con los datos del control interno y externo, lo que puede llevar a la inacción frente a la prevención de la enfermedad.

7.2. RECOMENDACIONES

- Al Centro de Salud Zárata, fortalecer las campañas de sensibilización multidisciplinaria, para grupos con antecedentes familiares, dado que estos tienen una mayor predisposición al riesgo de diabetes, es recomendable implementar programas de educación dirigidos específicamente a este grupo, para elevar su percepción de riesgo del nivel medio al alto, donde el conocimiento y las prácticas preventivas puedan consolidarse.
- Al personal de salud en general, desarrollar intervenciones focalizadas para personas con factores de riesgo presentes, para abordar el "sesgo optimista" en personas con sobrepeso, hipertensión u otras enfermedades metabólicas, se recomienda la creación de intervenciones que resaltan los riesgos reales y potenciales de desarrollar diabetes. Estas intervenciones deben incluir información personalizada y accesible sobre las consecuencias de los factores de riesgo presentes, así como ofrecer un seguimiento clínico y programas de apoyo comunitario.
- Al personal de enfermería, promover estrategias que incrementen el empoderamiento de las personas para manejar los factores de riesgo, promoviendo un sentido de control personal y fomentando la responsabilidad individual en la prevención de la diabetes.
- A los investigadores en el tema, se sugiere realizar estudios longitudinales que midan el impacto de los programas de educación y prevención en la percepción de riesgo a lo largo del tiempo. Esto permitiría evaluar si las intervenciones realmente aumentan la percepción de riesgo o si, como sugieren Alzaben et al., el nivel de percepción se mantiene invariable, lo que requeriría ajustar las estrategias utilizadas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. OMS. Enfermedades no transmisibles. [Online].; 2021 [cited 2022 junio 1]. Available from: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases>.
2. Gómez-Peralta F, AC, CX, y GHR. ¿ Cuándo empieza la diabetes? Detección e intervención tempranas en diabetes mellitus tipo 2. Revista Clínica Española. 2020 junio-julio; 220(5).
3. ALCOCER BS, VALLE ARC, CEH JGG. Identificación de Factores de Riesgo de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en Adultos de 30 a 60 Años de edad en la Comunidad de Isla Aguada, Municipio de Ciudad del Carmen, Campeche. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo: RIDE. 2015 enero-junio; 5(10).
4. OMS. Organización Mundial de la Salud. [Online].; 2021 [cited 2022 junio 1]. Available from: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diabetes>.
5. INEI. Instituto Nacional de Estadística e Informática. [Online].; 2020 [cited 2022 junio 1]. Available from: <https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-399-de-peruanos-de-15-y-mas-anos-de-edad-tiene-al-menos-una-comorbilidad-12903/#:~:text=En%20el%20a%C3%B1o%202020%2C%20el%204%2C%25%20de%20la,hombres%20al%204%2C%25%20>
6. Yadicelis Llorente Columbié PEMSDR. Factores de riesgo asociados con la aparición de diabetes mellitus tipo 2 en personas adultas. Revista Cubana de Endocrinología. 2016; 27(2).
7. Leyton. MR. Factores de riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en población adulta. Barranquilla, Colombia. Revista Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. 2019 mayo; 6(2).
8. Ana-María Leiva MAMFPAGMFPVXDMCCM. Factores asociados al desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 en Chile. Nutrición Hospitalaria. 2018 marzo-abril; 35(2).

9. Federación Internacional de Diabetes. Datos y cifras de la Diabetes. [Online].; 2021 [cited 2023 setiembre 30. Available from: <https://idf.org/about-diabetes/diabetes-facts-figures/>.
10. De la Rosa J,AM,&SP. Estilos de vida y su influencia en la aparición de complicaciones en la diabetes mellitus tipo 2 en la población de esmeraldas. Ecuador.. Universidad Ciencia y Tecnología. 2018; 22(89).
11. Miryam L, Fátima F, Karen QMyI. Contribuciones médicas para prevenir la diabetes mellitus tipo II. Universidad Ciencia y Tecnología. 2019; 23(95).
12. José Luis Álvarez Suarez FdCADFyMMM. Manual de Valoración de Patrones Funcionales.. Dirección de Enfermería de Atención Primaria.. 2010.
13. Juan Manuel Fabra Heredia LCiM. Relación entre el estilo de vida de un joven deportista de alto rendimiento y los patrones funcionales de salud de Marjory Gordon. 2014 enero.
14. Fuenmayor G, Villasmil Y. La percepción, la atención y la memoria como procesos cognitivos utilizados para la comprensión textual. Revista de Artes y Humanidades UNICA. 2008 mayo-agosto; 9(22).
15. Álvarez MVS, González MTGMyEV. La percepción directiva: influencia del perfil cognitivo y de factores contextuales. Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa. 2011 abril; 14(2).
16. René Rico Sánchez AJLMSPyLdRMA. Nivel de Conocimientos, Estilos de Vida y Control Glicémico en Pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2. Ene. 2020 abril; 12(1).
17. GUTIERREZ DGQ. TEORÍA DE DOROTHEA OREM- PROCESO ATENCIÓN DE ENFERMERÍA APLICADO AL AUTOCUIDADO DEL ADULTO MAYOR DIABÉTICO EN EL HB-7 LOJA. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 2019.
18. Pelullo CP,RR,NR,NF,yDGG. Prevención de la Diabetes: Conocimiento y Percepción del Riesgo entre la Población Italiana. BioMed Research International. 2019 octubre; 2019.

19. Sánchez BV,RJLB,PEV,CMC,&TGZ. Percepción de riesgo de desarrollar diabetes mellitus en personas no diabéticas.. Revista de Enfermedades no Transmisibles Finlay. 2016; 6(2).
20. Khan RK,MR,SBS,&WS. Predictores de la percepción del riesgo de diabetes entre estudiantes universitarios. Journal of American College Health. 2020 enero;(1-7).
21. Janet Antwi RLSSyMB. Percepción y factores de riesgo de diabetes tipo 2 entre estudiantes que asisten a una universidad del norte del estado de Nueva York: un estudio piloto. Diabetología y síndrome metabólico (BioMed Central). 2020 marzo; 12(1).
22. Vaja I, Umeh K, Abayomi JC, Newson TPyL. Una teoría fundamentada sobre la prevención de la diabetes tipo 2 y la percepción de riesgos. Revista Británica de Psicología de la Salud (Wiley). 2021; 26(3).
23. Nguyen AP. "Risk perception of developing diabetes: A concept analysis." Nursing Forum. 2020 mayo; 55(4).
24. Lopez-Jaramillo P, Lopez-Lopez J, Cohen DD, Mogollón-Zehr NAA&M. "Epidemiology of hypertension and diabetes mellitus in Latin America.". Current Hypertension Reviews. 2021 enero; 17(2).
25. Rocca J, Calderón M, Rosa AL, Seclén S, Castillo Ó, Pajuelo J, et al. "Type 2 diabetes mellitus in Peru: A literature review including studies at high-altitude settings.". Diabetes Research and Clinical Practice. 2021 noviembre; 182.
26. Catalina Rochefort ASBJTyMEB. Evaluación de la validez de la encuesta de percepción de riesgo para el desarrollo de la escala de diabetes en una población clínica de red de seguridad de habla inglesa y española. The Diabetes Educator. 2020 Noviembre; 46(1).
27. Jia Guo YJTHLyJLC. El riesgo, percibido y real, de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 para madres de niños en edad preescolar en zonas urbanas de China. PloS one. 2019 Setiembre; 14(9).

28. Ángela Koipuram SCZPyDS. Conocimiento de la diabetes, percepción del riesgo y calidad de vida entre los cuidadores del sur de Asia en la edad adulta joven. *BMJ Open Diabetes Research and Care*. 2020 noviembre; 8(2).
29. Sulaiman S,LM,&NAW. Risk perception and knowledge regarding diabetes among offspring of type 2 diabetics at a tertiary institution.. *The Medical Journal of Malaysia*. 2020 noviembre; 75(6).
30. Khlaifat Ali AHLDRySN. Encuesta transversal sobre el conocimiento, las percepciones de riesgo y las prácticas sobre diabetes entre estudiantes universitarios en el sur de Jordania. *Revista de diabetes y trastornos metabólicos (Springer Science and Business Media LLC)*. 2020 julio; 19(2).
31. Abeer S Alzaben HMB,NIA,AAA,NAANB. La influencia de un programa de concientización sobre la diabetes en el conocimiento, la percepción de riesgos y las prácticas sobre diabetes entre estudiantes universitarios. *Primary Care Diabetes*. 2023 mayo.
32. Jimenez-Tolentino KM, Armenta-Rodríguez I, Ramírez-Girón ISSyN. PERCEPCIÓN DE RIESGO SOCIO ECOLÓGICO PARA DIABETES TIPO 2 EN ADULTOS MEXICANOS. *CuidArte*. 2022 Agosto; 11(22).
33. Girón DdlVyNR. Percepción y conocimiento de Diabetes tipo 2 y riesgo de diabetes en adultos.. *Revista Uruguaya de Enfermería (En línea)*. 2024; 19(1).
34. Jazmín López-Escamilla LVPMAJCCGMCULSyJÁG. Percepción de riesgo y riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en estudiantes universitarios mexicanos. *Archivos de Medicina (Manizales)*. 2024; 24(2).
35. Udler PRyMS. Patogenia de la diabetes mellitus tipo 2. 2021 diciembre.
36. Balasubramanyam A. Clasificación de la diabetes mellitus y los síndromes diabéticos genéticos. 2021 diciembre.
37. Khamis AM. "Pathophysiology, Diagnostic Criteria, and Approaches to Type 2 Diabetes Remission.". 2023 Enero; 15(1).

38. Rey-Reñones C, Baena-Díez JM, Aguilar-Palacio I, Grau CM&M. "Type 2 diabetes mellitus and cancer: Epidemiology, physiopathology and prevention." *Biomedicines*. 2021 Octubre; 19(10).
39. Dumoy JS. Los factores de riesgo. *Revista Cubana de Medicina General Integral*. 1999 julio-agosto; 15(4).
40. Ana-María Leiva MAMFPAGMFPVXDMyCC. Factores asociados al desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 en Chile. *Nutrición Hospitalaria*. 2018 maro - abril; 35(2).
41. Luisa Cecilia Altamirano Cordero MAVC,GCRÁRAJRVB. Prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 y sus factores de riesgo en individuos adultos de la ciudad de Cuenca- Ecuador. *Avances en Biomedicina*. 2017 abril; 6(1).
42. Cabriales MHMyECG. Riesgo de diabetes mellitus tipo 2 y sus determinantes. *Enfermería Global*. 2022 enero-marzo; 21(65).
43. International Diabetes Federation. Atlas de la Diabetes de la FID, novena edición. [Online].; 2019 [cited 2022 junio 23. Available from: https://www.diabetesatlas.org/upload/resources/material/20200302_133352_2406-IDF-ATLAS-SPAN-BOOK.pdf.
44. Shai I, Jiang R, Manson JE, Stampfer MJ, Willett WC, Hu GACyFB. Origen étnico, obesidad y riesgo de diabetes tipo 2 en mujeres: un estudio de seguimiento de 20 años. *Diabetes care*. 2006 julio; 29(7).
45. Bancks MP,KK,CAP,GLP,SPJ,yCMR. Association of modifiable risk factors in young adulthood with racial disparity in incident type 2 diabetes during middle adulthood.. 2017 diciembre; 318(24).
46. InterAct Consortium
SRLCSSFPRODDvdSYEUKNAEALBBBABIBBBJBHdLGBD. The link between family history and risk of type 2 diabetes is not explained by anthropometric, lifestyle or genetic risk factors: the EPIC-InterAct study. *Diabetología*. 2013 setiembre; 56(1).
47. Robertson P. Type 2 diabetes mellitus: Prevalence and risk factors. 2022 enero.

48. Vujkovic M, Keaton JM, Lynch JA, Miller DR, Zhou J, Tcheandjieu C, Huffman JE, Assimes TL, Lorenz K, Zhu X, Hilliard AT, Judy RL, Huang J, Lee KM, Klarin D, Pyarajan S, Danesh J, Melander O, Rasheed A, Mallick NH, Hameed S, Qureshi IH, Afzal MN et al. Discovery of 318 new risk loci for type 2 diabetes and related vascular outcomes among 1.4 million participants in a multi-ancestry meta-analysis. *Genética de la Naturaleza*. 2020 julio; 52(7).
49. Durnwald C. Gestational diabetes mellitus: Screening, diagnosis, and prevention. 2020 julio.
50. Chávez-Courtois M,GC,RPI,SMG,SJB,yPPO. Experiencia y percepciones de la diabetes gestacional y su automanejo en un grupo de mujeres multíparas con sobrepeso.. *Ciência & Saúde Coletiva*. 2014; 19(6).
51. OMS. Obesidad y Sobrepeso. [Online].; 2021 [cited 2022 agosto 23. Available from: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight#:~:text=El%20sobrepeso%20y%20la%20obesidad%20se%20definen%20como%20una%20acumulaci%C3%B3n,la%20obesidad%20en%20los%20adultos.>
52. Teufel F,SJA,GP,TM,MME,EC.&MGJ. Body-mass index and diabetes risk in 57 low-income and middle-income countries: a cross-sectional study of nationally representative, individual-level data in 685 616 adults. *The Lancet (Inglaterra)*. 2021 julio; 398(10296).
53. Andy Menke KFR,JF,YJC,CC. Asociaciones entre tendencias en raza/etnicidad, envejecimiento e índice de masa corporal con prevalencia de diabetes en los Estados Unidos: una serie de estudios transversales. *Anales de Medicina Interna*. 2014 septiembre; 161(5).
54. Esther Zimmerman 1 LGBMGAAVTISJP. Childhood body mass index and development of type 2 diabetes throughout adult life-A large-scale danish cohort study. *Obesity (Silver Spring)*. 2017 mayo; 25(5).

55. Organización Mundial de la Salud (OMS). Alimentación sana. [Online].; 2018 [cited 2022 Agosto 25. Available from: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>.
56. Evelia Ortiz Contreras LEBEERPRLESEGSBSLI. Frecuencia de “riesgo elevado de desarrollar diabetes” en pacientes de una clínica de medicina familiar. Atención familiar: Órgano de difusión científica del Departamento de Medicina Familiar. 2013; 20(3).
57. Ministerio de Salud y Protección social. ¿Qué es una alimentación saludable? [Online].; 2022 [cited 2022 agosto 25. Available from: <https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/HS/Paginas/que-es-alimentacion-saludable.aspx>.
58. MIRIAM VF, DIEGO DR, ANAYS AR. Conocimiento del adulto mayor sobre la alimentación balanceada.. In aniversariocimeq2021. 2021 marzo.
59. Ramírez JN. EFECTO DEL CONSUMO DE FIBRA EN LA DIETA DEL PACIENTE DIABÉTICO. REVISTA MEDICA DE COSTA RICA Y CENTROAMERICA. 2012; 69(600).
60. Guzmán-Pereira MyMLC. "Beneficios de la reducción del consumo de azúcares y aumento de la actividad física en adultos jóvenes con obesidad y la prevención de la diabetes.". Acta Académica. 2020 Noviembre; 67.
61. Hirsch IB. Patient education: Type 2 diabetes: Alcohol, exercise, and medical care (Beyond the Basics). 2019 febrero.
62. Xiang Qian Lao HBD1XLTCZZLYCEKYTTMCSWGNT. Increased leisure-time physical activity associated with lower onset of diabetes in 44 828 adults with impaired fasting glucose: a population-based prospective cohort study. British Journal of sports medicine. 2018 enero; 53(14).
63. Ramón Gomis SAPCJVRCyBF. Prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes ambulatorios con sobrepeso u obesidad en España. Estudio OBEDIA. Medicina Clínica. 2014 junio; 142(11).

64. Petermann F,G. Tiempo destinado a estar sentado y niveles de adiposidad ¿Cuál es su efecto sobre el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2? Revista Medica de Chile. 2018 abril; 146(4).
65. Ana Gladys Aráuz Hernández SGPMRA. La circunferencia abdominal como indicador de riesgo de enfermedad cardiovascular. Acta Médica Costarricense. 2013 Setiembre ; 55(3).
66. JIMÉNEZ JIMÉNEZ A. RELACION DEL PERÍMETRO ABDOMINAL Y DIABETES MELLITUS 2. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL. 2015.
67. Richard Giovanni Buendía MZAMAALGDGSVSM. Perímetro de cintura aumentado y riesgo de diabetes. Acta Médica Colombiana. 2016 julio - setiembre ; 41(3).
68. Rigotti NA. Patient education: Quitting smoking (Beyond the Basics). 2021 enero.
69. Robertson RP. Prevention of type 2 diabetes mellitus. 2021 octubre.
70. Oviedo GL. LA DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE PERCEPCIÓN EN PSICOLOGÍA CON BASE EN LA TEORÍA GESTALT. Revista de Estudios Sociales. 2004; 18.
71. Angélica María Razo González R. Percepción del estado de salud y la calidad de vida en personas jóvenes, maduras y mayores. CONAMED. 2018; 23(2).
72. Kollmann J, Benyamini Y, Renner. El papel de la experiencia de riesgo personal: una investigación de la percepción del riesgo de terrorismo y salud en Alemania e Israel. Risk analysis. 2022 Agosto; 42(4).
73. Öhman S. "Previous experiences and risk perception: The role of transference.". Journal of Education, Society and Behavioural Science. 2017; 23(1).
74. Linden S. The social-psychological determinants of climate change risk perceptions: Towards a comprehensive model.". Journal of Environmental Psychology. 2015 Marzo; 41.

75. Reyna Cea. "Propiedades psicométricas de las escalas de percepción de riesgo del cambio climático en habitantes de la ciudad de Córdoba, Argentina." *Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento*. 2020 Agosto.
76. Cornejo Aea. Percepción de riesgo, creencias y normas subjetivas de la conducta proambiental en pobladores del sector ladrillero del distrito de San Jerónimo, Cusco, 2019.". *Ambiente, Comportamiento y Sociedad*. 2019; 2.
77. Jhon Alex Zeladita-Huaman ea. "Desarrollo y validación de una escala de percepción de riesgo de COVID-19 en Perú." *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica*. 2023 Abril-Junio; 40(2).
78. Shumye M. La percepción del riesgo modera la forma en que el conocimiento se traduce en intenciones de tomar medidas preventivas contra las enfermedades no transmisibles (ENT). 2023 Abril.
79. Vornanen M, Konttinen H, Haukkala MPyA. "Diabetes and Cardiovascular Disease Risk Perception and Risk Indicators: a 5-Year Follow-up.". *International Journal of Behavioral Medicine*. 2021 junio; 28(3).
80. Jizhe Wang YW,ML,LX,XHLXZ. "Risk Perception Scale of Disease Aggravation for older patients with non-communicable diseases: Instrument development and cross-sectional validation study." *Journal of Advanced Nursing*. 2023 Julio.
81. Sağlam FSyHB. "Risk perceptions of patients with type 2 diabetes mellitus regarding insulin therapy and diabetes complications: A cross-sectional study." *Journal of Clinical Nursing*. 2023 Abril.
82. Syahril Yusnaena YMaYDR. Improving Employee Performance Through Perception oh internal locus of control external locus of control at PT. Hayati Padang (A study on motorcycle dealers in Padang City). *Revista Internacional de investigación y revisión*. 2023 mayo; 10(5).
83. Lauren Wadsworth IWCBaTB. Niveles de control percibido y respuesta al tratamiento en un entorno hospitalario parcial breve. *Neurología, Psiquiatría e Investigación del Cerebro (Elsevier)*. 2019 diciembre; 1(34).

84. Nowicka-Sauer WRLaK. Percepción de la enfermedad y beneficios percibidos de la enfermedad entre personas con diabetes tipo 1. Informe Psicología de la Salud. 2023 noviembre; 11(3).
85. Kevin L. Joiner RMSCKJLCYFSLJ. A Spanish-language risk perception survey for developing diabetes: translation process and assessment of psychometric properties. Journal of nursing measurement. 2016 diciembre; 24(3).
86. Villota Luna D. Los patrones funcionales de Marjory Gordon y su aplicación en el contexto clínico desde el enfoque de enfermería. 2022 diciembre.
87. Mónica Arnold Rodríguez. Pesquisaje y prevención de la diabetes mellitus tipo 2 en población de riesgo. Revista Cubana de Higiene y Epidemiología. 2012 setiembre - diciembre; 50(3).
88. CABRERA YÁNEZ RA. El impacto emocional en pacientes diabéticos relacionados con el manejo de la enfermedad: Una aproximación bibliográfica. Universidad Tecnológica Indoamérica, Tesis de Licenciatura. 2021.
89. Adrián Marcelo Parra Peralta RLRGIAPÁAOO. La Inteligencia emocional en pacientes miembros de la Fundación Casa de la Diabetes Cuenca, Ecuador. Revista Cubana de Educación Superior. 2018 mayo - agosto; 37(2).
90. Seclén S. Diabetes Mellitus en el Perú: hacia dónde vamos. Revista Medica Herediana. 2015 enero; 26(1).
91. Aída Jiménez-Corona. Diabetes mellitus tipo 2 y frecuencia de acciones para su prevención y control. Salud Pública de México. 2013; 55.
92. Ydalsys Naranjo Hernández JACPyMRL. La teoría Déficit de autocuidado: Dorothea Elizabeth Orem. Gaceta Médica Espirituana. 2017 setiembre-diciembre; 19(3).
93. Gladis Patricia Aristizábal Hoyos DMBASRRMOM. El modelo de promoción de la salud de Nola Pender. Una reflexión en torno a su comprensión. Enfermería Universitaria. 2011 octubre-diciembre; 8(4).

94. Ngwazini C. Implementación del "Plan de evaluación clínica para la promoción de la salud" de Nola Pender para aumentar la autoeficacia del paciente, la pérdida de peso y los comportamientos que promueven la salud". 2022 mayo.
95. Daniela Bulcão Santi ISN,VADB. Modelo de Nola Pender para promoción de la salud adolescente. 2023 abril; 27.
96. Mendoza RHSyC. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: LAS RUTAS CUANTITATIVA, CUALITATIVA Y MIXTA Mcgraw-hill , editor.; 2020.
97. Rafael Wilfredo Medina Yancán. ANALISIS DE LA SITUACION DE SALUD DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO. MINSA-DIRIS Lima Centro. 2019 Noviembre.
98. Meza HHSC&CR. METODOLOGÍA Y DISEÑOS EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. Quinta edición. Lima: Business Support Aneth; 2017.
99. Sandú A. El Consentimiento Informado - Como Herramienta Protectora del Derecho a la Autonomía y a la Dignidad de los Sujetos Humanos que Participan en Investigaciones Biomédicas, en el Contexto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Jurnalul de studii juridice. 2022 Marzo; 16(3).
100. ERIKSON EH. Estadios fundamentales del desarrollo psicosocial. En El ciclo vital completado. 1985.
101. Martínez RMF. Vejez, violencia y dependencia: un análisis desde los aspectos jurídicos de. Revista de Temas Sociales. 2018 noviembre; 42(3).
102. Bernabé-Ortiz RMCLyA. Diabetes mellitus tipo 2 en Perú: una revisión sistemática sobre la prevalencia e incidencia en población general. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica. 2019 enero-marzo; 36(1).
103. INEI DCB. Situación de la población Adulta Mayor. Informe Técnico. Lima: INEI, Lima; 2022.
104. Rodríguez-Laso Á. Updated state of the art report on the prevention and management of frailty. Joint Action '724099 / ADVANTAGE'. 2019 agosto.

105. Lizeth I. Chuquipoma-Quispe. Factores asociados al síndrome de fragilidad en adultos mayores que acuden a consulta externa de Geriátría del Hospital Nacional Hipólito Unanue, Lima-Perú. *Acta Médica Peruana*. 2019 octubre-diciembre; 36(4).
106. Erick Acosta-Illatopa. SÍNDROME DE FRAGILIDAD EN ADULTOS MAYORES DE UNA COMUNIDAD RURAL DE LOS ANDES PERUANOS. *Revista de la Facultad de Medicina Humana*. 2021 abril; 21(2).
107. Karla Berenice Carrazco-Peña KFMBTHIDE. Frecuencia de fragilidad y comorbilidad en adultos mayores. *Revista Argentina de Gerontología y Geriátría*. 2019 julio; 33(2).
108. Esquinas-Requena JL, Lozoya-Moreno S, García-Nogueras I, Atienzar-Núñez P, Sánchez-Jurado PM, Abizanda P. La anemia aumenta el riesgo de mortalidad debido a fragilidad y discapacidad en mayores: Estudio FRADEA. *Atención Primaria*. 2020 agosto-setiembre; 52(7).
109. Hsueh L,PJM,HAT,dGM,ySJC. Diabetes risk perception among immigrant and racial/ethnic minority adults in the United States. *The Diabetes Educator*. 2019 setiembre; 45(6).
110. Kim C.E. Risk perception for diabetes among women with histories of gestational diabetes mellitus.. *Diabetes Care*. 2007 junio; 30(9).
111. Rosenda Murillo BJKTGIVySE. La asociación de la percepción del riesgo de prediabetes y diabetes con la actividad física en el tiempo libre y la pérdida de peso. *American Journal of Health Promotion*. 2019 mayo; 33(4).
112. Sánchez BV,RJLB,PEV,CMC,yTGZ. Percepción de riesgo de desarrollar diabetes mellitus en personas no diabéticas.. *Revista de Enfermedades no Transmisibles Finlay*. 2016 abril-junio; 6(2).
113. Manas F.F. Diabetes mellitus tipo 2 en el anciano, nueva evidencia para aplicar el conocimiento a la práctica clínica diaria. *Revista Española de Geriátría y Gerontología*. 2013; 48(2).

114. Rochefort C, Baldwin AS, Bowen JTyME. Evaluating the validity of the risk perception survey for developing diabetes scale in a safety-net clinic population of English and Spanish speakers. *The Diabetes Educator*. 2020; 46(1): p. 73-82.
115. Simmons S. Risk Perceptions for Type 2 Diabetes Mellitus Among College Students. 2018 mayo.
116. Delphine Eeckhout KA,CVDS. Consentimiento informado: perspectivas del personal de investigación y recomendaciones prácticas para mejorar la comunicación entre el personal de investigación y los participantes. *Revista de investigación empírica sobre ética de la investigación humana*. 2022 diciembre; 18(1).

ANEXOS

Índice de Anexos

- A. Operacionalización de variable
- B. Cálculo tamaño de muestra
- C. Instrumento
- D. Informe de Juicio de experto
- E. Libro de códigos
- F. Matriz de datos
- G. Consentimiento informado
- H. Tablas como anexo

ANEXO A: Operacionalización de la variable

Variable	Definición conceptual	Dimensiones	Indicadores/	Valor final	Definición operacional
Percepción de riesgo de la diabetes	Impresión y estimación subjetiva de un estímulo determinado que se interpreta a base de conocimientos previos, ideas, pensamientos, etc., acerca de los factores de riesgo, modificable y no modificables, de la enfermedad Diabetes Mellitus tipo 2.	Sesgo Optimista	1. En comparación con otras personas que tienen mi edad y mi mismo sexo , tengo menos probabilidad que ellos en tener diabetes mellitus tipo 2.	Percepción de Riesgo alta Percepción de Riesgo moderada Percepción de Riesgo baja	Valoración subjetiva de los factores de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2 de los adultos, que está influenciada por conocimientos previos, situaciones que involucren a la enfermedad, emociones, factores socioculturales, etc., que se obtendrá mediante una escala de Likert modificada, donde el valor mínimo del enunciado es 1 punto y el máximo 4 puntos. La escala de valoración según máximos y mínimos (ANEXO 6) dan como valores finales en Percepción de riesgo bajo
			2. En comparación con otras personas que tienen mi edad y mi mismo sexo , tengo menos probabilidad que ellos en desarrollar cualquier enfermedad grave o severa .		
		Control interno y externo	3. Creo que mis esfuerzos personales (como ir al médico o priorizar mi salud) me ayudarán a controlar/disminuir el riesgo que tengo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2.		
			4. Creo que mis hábitos alimenticios (ejemplo: manera de preparar los alimentos, comer ciertos alimentos todos los días, beber agua, etc.) me ayudarán a controlar el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2.		
			5. Creo que mi estilo de vida (actividades que realizo todos los días o como rutina) me ayudará a controlar el riesgo de tener diabetes mellitus tipo 2.		

		6. Creo que el nivel de actividad física que realizo (ejemplo: caminar, correr, bailar, realizar deportes, etc.) me ayudará a controlar el riesgo de tener diabetes mellitus tipo 2. 7. Las personas que hacen esfuerzo para controlar los riesgos de contraer diabetes, tienen menos probabilidades de tener diabetes tipo 2. 8. Las personas que tiene una alimentación balanceada (alimentarse según peso, edad, sexo y estilo de vida) tienen menos probabilidades de contraer diabetes tipo 2. 9. Las personas que no tienen hábitos nocivos (ejemplo: fumar, tomar bebidas alcohólicas, etc.) tienen menos probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2. 10. Siento que tengo poco control sobre los riesgos para mi salud. 11. Siento que tengo poco control sobre el consumo de alimentos ricos en grasas y azúcar. 12. Siento que tengo poco control en las actividades que me mantienen en sedentarismo (estar mucho tiempo sentado o acostado, sin hacer actividad física) la mayor parte del día. 13. Si estoy destinado a tener diabetes mellitus tipo 2, no hay nada que pueda hacer al respecto.	entre 17 a 34 puntos, Percepción de riesgo medio o moderado de 35 a 51 puntos y Percepción de riesgo alta de 52 a 68 puntos.
--	--	---	---

			14. Si me dicen que podría tener diabetes, no está en mis manos mejorar o mantener mi salud.		
		Preocupación	15. Me preocupa tener o desarrollar diabetes mellitus tipo 2.		
			16. Preocuparse por tener diabetes no nos da la solución, pero es necesario.		
			17. Preocuparse por tener diabetes mellitus tipo 2 es muy perturbador o incómodo.		

ANEXO B: Fórmula de población finita

$$n = Z_{\alpha}^2 \frac{N \cdot p \cdot q}{i^2 (N - 1) + Z_{\alpha}^2 \cdot p \cdot q}$$

Donde:

- **n** = Tamaño muestral
- **N** = Tamaño de la población, número total de elementos de la población.
- **Z** = Valor encontrado en la tabla de la distribución Normal, **1.96** para $\alpha = 0.05$ y
- **p** = Proporción esperada de la característica a evaluar. En caso de desconocerse, aplicar la opción más favorable ($p=0,5$), que hace mayor el tamaño muestral.
- **q** = $1-p = 0,5$
- **“i” o “d”** Error que se comete al escoger la muestra, para $\alpha = 0.05$ es un **i = 0.1**

Muestra de la investigación:

$$n = \frac{(1.96)^2 \times 1200 \times 0.5 \times 0.5}{(0.05)^2 \times (1200-1) + (1.96)^2 \times 0.5 \times 0.5}$$

$$n = \frac{1152.48}{2.9975 + 0.9604}$$

$$n = \frac{1152.48}{3.9579} = > \quad \mathbf{n = 291.185}$$

ANEXO C: Instrumento

Escala de Likert de Percepción de Riesgo de la Diabetes Mellitus tipo 2

Instrumento del Proyecto de Investigación: PERCEPCIÓN DE RIESGO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN ADULTOS QUE ACUDEN A UN CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 2024

Fecha: ____/____/____

Código

Presentación

Estimados usuarios, soy Bachiller de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estoy realizando un estudio que tiene como objetivo determinar la percepción de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2 en adultos que acuden a un Centro de Salud de San Juan de Lurigancho, 2024, para lo cual solicito su colaboración para responder con la mayor sinceridad, así mismo señalar que la información que proporcionará es anónima y se utilizará con fines académicos.

Agradezco de antemano su colaboración.

Instrucciones



Llene y lea detenidamente las preguntas del bloque Datos generales y marque (X) una de las opciones o escriba la respuesta.



Marque solo una respuesta

Datos Generales

1. ¿Cuántos años tiene? años

2. Sexo:

☐ Femenino

☐ Masculino

3. Grado de instrucción alcanzado ☐ Primaria

☐ Secundaria

☐ Educación superior técnica

☐ Educación superior universitaria

4. Estado civil

☐ Casado

☐ Soltero

☐ Conviviente

☐ Viudo/Divorciado

5. ¿Ha tenido o tiene parientes (padres, tíos o abuelos) con diabetes mellitus tipo 2?

☐ Sí☐ No

6. ¿Ha tenido o tiene alguna de las siguientes enfermedades?

☐ Hipertensión arterial

- Sobrepeso
- Obesidad

☐ Otra enfermedad metabólica(hipotiroidismo)

7. Qué seguro de salud tiene actualmente vigente

☐ SIS☐ EsSalud ☐ Otro

Escala de Likert de la Percepción de Riesgo de la Diabetes



Lea detenidamente y marque con un aspa (X) la respuesta que considere



Solo debe marcar un recuadro por enunciado

Contenido

Enunciados	Muy en desacuerdo	En Desacuerdo	De Acuerdo	Muy de acuerdo
1. En comparación con otras personas que tienen mi edad y mi mismo sexo , tengo menos probabilidad que ellos en tener diabetes mellitus tipo 2.				
2. En comparación con otras personas que tienen mi edad y mi mismo sexo , tengo menos probabilidad que ellos en desarrollar cualquier enfermedad grave o severa .				
3. Creo que mis esfuerzos personales (como ir al médico o priorizar mi salud) me ayudarán a controlar/disminuir el riesgo que tengo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2.				
4. Creo que mis hábitos alimenticios (ejemplo: manera de preparar los alimentos, comer ciertos alimentos todos los días, beber agua, etc.) me ayudarán a controlar el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2.				

5. Creo que mi estilo de vida (actividades que realizo todos los días o como rutina) me ayudará a controlar el riesgo de contraer diabetes mellitus tipo 2.				
6. Creo que el nivel de actividad física que realizo (ejemplo: caminar, correr, bailar, realizar deportes, etc.) me ayudará a controlar el riesgo de tener diabetes mellitus tipo 2.				
7. Las personas que hacen esfuerzo para controlar los riesgos de contraer diabetes, tienen menos probabilidades de tener diabetes.				
8. Las personas que tiene una alimentación balanceada (alimentarse según peso, edad, sexo y estilo de vida) tienen menos probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2.				
9. Las personas que no tienen hábitos nocivos (ejemplo: fumar, tomar bebidas alcohólicas, etc.) tienen menos probabilidades de tener diabetes tipo 2.				
10. Siento que tengo poco control sobre los riesgos para mi salud.				
11. Siento que tengo poco control sobre el consumo de alimentos ricos en grasas y azúcar.				
12. Siento que tengo poco control en las actividades que me mantienen en sedentarismo (estar mucho tiempo sentado o acostado, sin hacer actividad física) la mayor parte del día.				
13. Si estoy destinado a tener diabetes mellitus , no hay nada que pueda hacer al respecto.				
14. Si me dicen que podría tener diabetes, no está en mis manos mejorar o mantener mi salud.				
15. Me preocupa tener o desarrollar diabetes mellitus tipo 2 .				
16. Preocuparse por tener diabetes no nos da la solución, pero es necesario.				
17. Preocuparse por tener diabetes mellitus tipo 2 es muy perturbador o incómodo.				

ANEXO D: Informe de Juicio de Experto

Claridad

ÍTEMS	J1	J2	J3	Σ	(Mx)	CVCi	Pei	CVCic
1	4	3	5	12	4	1	0.037	0.963
2	4	3	5	12	4	1	0.037	0.963
3	4	2	5	11	3.6666667	0.9166667	0.037	0.8796667
4	4	2	5	11	3.6666667	0.9166667	0.037	0.8796667
5	3	3	5	11	3.6666667	0.9166667	0.037	0.8796667
6	3	3	5	11	3.6666667	0.9166667	0.037	0.8796667
7	3	3	5	11	3.6666667	0.9166667	0.037	0.8796667
8	3	3	5	11	3.6666667	0.9166667	0.037	0.8796667
9	4	2	5	11	3.6666667	0.9166667	0.037	0.8796667
10	4	2	5	11	3.6666667	0.9166667	0.037	0.8796667
11	4	1	5	10	3.3333333	0.8333333	0.037	0.7963333
12	4	2	5	11	3.6666667	0.9166667	0.037	0.8796667
13	4	2	5	11	3.6666667	0.9166667	0.037	0.8796667
14	4	1	5	10	3.3333333	0.8333333	0.037	0.7963333
15	3	2	5	10	3.3333333	0.8333333	0.037	0.7963333
16	3	2	5	10	3.3333333	0.8333333	0.037	0.7963333
17	2	2	5	9	3	0.75	0.037	0.713
18	2	2	5	9	3	0.75	0.037	0.713
19	2	2	5	9	3	0.75	0.037	0.713
20	2	2	5	9	3	0.75	0.037	0.713
							Σ	16.76
		N° Ítems	20				CVct	0.838
							CVC	0.801

Relevancia

ÍTEMS	J1	J2	J3	Σ	(Mx)	CVCi	Pei	CVCic
1	4	2	5	11	3.667	0.917	0.037	0.880
2	4	3	5	12	4.000	1.000	0.037	0.963
3	4	1	5	10	3.333	0.833	0.037	0.796
4	4	1	5	10	3.333	0.833	0.037	0.796
5	4	4	5	13	4.333	1.083	0.037	1.046
6	5	4	5	14	4.667	1.167	0.037	1.130
7	5	4	5	14	4.667	1.167	0.037	1.130
8	5	4	5	14	4.667	1.167	0.037	1.130
9	5	4	5	14	4.667	1.167	0.037	1.130
10	5	3	5	13	4.333	1.083	0.037	1.046
11	5	1	5	11	3.667	0.917	0.037	0.880
12	5	2	5	12	4.000	1.000	0.037	0.963
13	5	2	5	12	4.000	1.000	0.037	0.963
14	5	2	5	12	4.000	1.000	0.037	0.963
15	5	2	5	12	4.000	1.000	0.037	0.963
16	5	2	5	12	4.000	1.000	0.037	0.963
17	3	2	5	10	3.333	0.833	0.037	0.796
18	3	2	5	10	3.333	0.833	0.037	0.796
19	3	2	5	10	3.333	0.833	0.037	0.796
20	3	2	5	10	3.333	0.833	0.037	0.796
							Σ	18.926
		N° Ítems	20				CVct	0.9462963
							CVC	0.909

ANEXO E: Libro de códigos

Datos generales

Edad	
Sexo	1. Femenino
	2. Masculino
Grado de instrucción alcanzado	1. Primaria
	2. Secundaria
	3. Educación superior técnica
	4. Educación superior universitaria
Estado civil	1. Casado
	2. Soltero
	3. Conviviente
	4. Viudo / divorciado
¿Ha tenido o tiene parientes (padres, tíos o abuelos) con diabetes mellitus tipo 2?	1. Sí
	2. No
¿Ha tenido o tiene alguna de las siguientes enfermedades?	1. Hipertensión arterial
	2. Sobrepeso (IMC $\geq$ 25 a 29.9 kg/m ²)
	3. Obesidad (IMC $\geq$ 30 kg/m ²)
	4. Otra enfermedad metabólica (resistencia a la insulina, hipotiroidismo, etc.)
	5. Ninguna enfermedad
¿Qué seguro de salud tiene actualmente vigente?	1. SIS
	2. EsSalud
	3. Otro

Contenido

Enunciados	Totalmente desacuerdo	En Desacuerdo	De Acuerdo	Totalmente de acuerdo
Sesgo Optimista				
1. En comparación con otras personas que tienen mi edad y mi mismo sexo , tengo menos probabilidad que ellos en tener diabetes mellitus tipo 2.	1	2	3	4
2. En comparación con otras personas que tienen mi edad y mi mismo sexo , tengo menos probabilidad que ellos en desarrollar cualquier enfermedad grave o severa .	1	2	3	4
Control interno				
3. Creo que mis esfuerzos personales (como ir al médico o priorizar mi salud) me ayudarán a controlar/disminuir el riesgo que tengo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2.	4	3	2	1
4. Creo que mis hábitos alimenticios (ejemplo: manera de preparar los alimentos, comer ciertos alimentos todos los días, beber agua, etc.) me ayudarán a controlar el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2.	4	3	2	1
5. Creo que mi estilo de vida (actividades que realizo todos los días o como rutina) me ayudará a controlar el riesgo de contraer diabetes mellitus tipo 2.	4	3	2	1
6. Creo que el nivel de actividad física que realizo (ejemplo: caminar, correr, bailar, realizar deportes, etc.) me ayudará a controlar el riesgo de tener diabetes mellitus tipo 2.	4	3	2	1
7. Las personas que hacen esfuerzo para controlar los riesgos de contraer diabetes, tienen menos probabilidades de contraer diabetes.				

8. Las personas que tiene una alimentación balanceada (alimentarse según peso, edad, sexo y estilo de vida) tienen menos probabilidades de contraer diabetes.	4	3	2	1
9. Las personas que no tienen hábitos nocivos (ejemplo: fumar, tomar bebidas alcohólicas, etc.) tienen menos probabilidades de contraer diabetes.	4	3	2	1
Control externo				
10. Siento que tengo poco control sobre los riesgos para mi salud.	1	2	3	4
11. Siento que tengo poco control sobre el consumo de alimentos ricos en grasas y azúcar.	1	2	3	4
12. Siento que tengo poco control en las actividades que me mantienen en sedentarismo (estar mucho tiempo sentado o acostado, sin hacer actividad física) la mayor parte del día.	1	2	3	4
13. Si estoy destinado a tener diabetes mellitus , no hay nada que pueda hacer al respecto.	1	2	3	4
14. Si me dicen que podría tener diabetes, no está en mis manos mejorar o mantener mi salud.	1	2	3	4
Preocupación				
15. Me preocupa tener o desarrollar diabetes mellitus tipo 2 .	1	2	3	4
16. Preocuparse por tener diabetes no nos da la solución, pero es necesario.	1	2	3	4
17. Preocuparse por tener diabetes mellitus es muy perturbador o incómodo.	1	2	3	4

Sujeto		Percepción de riesgo de la diabetes										Total general																		
		Datos generales						Dimensión 1: Sesgo optimista	Dimensión 2: Control interno y externo										Dimensión 3: Preocupación											
		Edad	Sexo	Grado de instrucción	Estado civil	Antecedentes familiares	Presencia de enfermedades	Seguro de salud	E1	E2	Subtotal		E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	Subtotal	E10	E11	E12	E13	E14	Subtotal	E15	E16	E17	Subtotal
1	30	2	2	3	1	5	1	3	4	7	1	1	1	1	1	1	1	7	1	2	1	1	1	6	13	4	3	10	30	
2	31	1	2	3	2	5	1	4	3	7	2	2	2	2	2	4	3	17	3	2	1	3	3	12	29	1	1	3	5	41
3	51	1	4	2	2	3	1	2	2	4	1	1	1	1	2	1	2	9	3	3	3	2	4	15	24	3	2	3	8	36
4	36	1	3	3	2	5	1	3	3	6	2	2	2	2	2	2	2	14	3	3	2	2	2	12	26	3	2	2	7	39
5	30	2	3	2	2	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	7	2	1	1	1	1	6	13	1	1	4	6	21
6	57	1	3	1	2	5	1	3	3	6	4	4	4	4	4	3	27	2	2	2	2	3	11	38	3	3	3	9	53	
7	39	1	2	3	2	4	1	3	3	6	2	2	2	2	2	2	15	3	3	3	2	3	14	29	3	3	3	9	44	
8	49	2	2	2	1	1	1	2	3	5	1	1	3	2	3	2	3	15	3	2	3	2	3	13	28	3	3	2	8	41
9	31	1	2	3	2	5	1	2	3	5	2	2	2	2	2	2	2	14	2	2	2	2	2	10	24	2	3	3	8	37
10	49	2	4	3	2	1	1	2	2	4	2	1	1	1	1	1	1	8	1	1	1	2	2	7	15	4	1	3	8	27
11	34	1	4	2	2	5	2	1	1	2	1	1	2	2	2	1	11	3	3	2	2	2	12	23	2	3	2	7	32	
12	31	1	4	2	1	5	1	4	3	7	2	2	2	2	3	3	3	17	2	2	2	2	2	10	27	2	2	2	6	40
13	30	1	4	3	2	5	1	3	2	5	2	2	2	2	2	2	2	14	3	2	2	2	2	11	25	3	3	3	9	39
14	36	1	2	3	2	4	1	3	3	6	3	2	2	2	2	2	4	17	1	2	2	3	4	12	29	3	3	4	10	45
15	42	1	3	3	2	3	3	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	8	2	2	2	1	1	8	16	4	4	4	12	30
16	39	1	3	2	2	5	1	2	4	6	1	1	2	1	2	1	4	12	4	2	2	2	2	12	24	2	2	2	6	36
17	59	2	3	2	1	5	1	2	3	5	2	2	2	2	2	2	2	14	3	3	2	2	2	12	26	3	3	2	8	39
18	36	2	3	2	2	5	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	13	1	1	2	1	1	6	19	3	4	4	11	32
19	36	1	4	1	2	5	1	3	3	6	2	2	2	2	2	2	2	14	2	2	2	2	2	10	24	3	3	3	9	39
20	30	2	3	3	1	5	1	1	2	3	2	2	1	2																

84	35	1	2	3	1	5	1	2	2	4	3	3	3	3	2	3	19	2	2	2	1	1	8	27	3	3	2	8	39
85	58	2	4	1	2	2	1	3	3	6	3	3	2	3	3	1	18	2	2	3	2	2	11	29	3	2	2	7	42
86	55	1	1	1	1	1	1	3	3	6	2	2	1	1	1	2	10	2	2	1	1	2	8	18	3	3	3	9	33
87	39	1	2	3	2	2	2	1	3	6	3	3	3	4	2	3	21	1	3	3	2	2	11	32	4	4	4	12	60
88	30	2	3	2	2	5	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	8	2	2	2	2	2	10	18	4	4	4	12	32
89	42	2	2	2	2	2	2	1	4	3	7	1	2	1	2	2	10	2	2	3	1	1	9	19	2	3	3	8	34
90	44	2	2	3	2	5	1	3	3	6	2	2	2	2	2	2	14	1	1	1	2	1	6	20	2	2	2	6	32
91	45	1	2	3	2	3	1	4	3	7	2	2	2	1	1	1	10	3	2	3	1	1	10	20	3	3	3	9	36
92	51	1	2	1	1	2	1	2	2	4	3	4	3	3	4	3	23	2	3	2	2	4	13	35	4	4	4	12	52
93	59	2	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	4	10	2	1	1	1	1	6	16	2	3	1	6	24
94	31	2	3	1	2	2	2	2	1	3	3	3	4	1	1	1	16	3	3	4	3	1	14	30	3	2	4	9	42
95	31	1	4	1	2	2	2	1	1	2	1	3	3	3	1	1	13	3	2	3	2	1	11	24	4	4	4	12	38
96	39	1	4	2	2	5	1	2	2	4	2	2	2	2	2	2	14	2	2	2	2	2	10	24	2	3	2	7	35
97	44	1	1	1	1	2	5	1	1	1	2	4	1	1	1	2	11	4	1	4	1	1	11	22	4	4	4	12	36
98	34	1	3	3	2	5	2	2	2	4	1	2	2	2	1	4	14	2	2	4	4	4	14	28	4	4	4	12	44
99	35	1	3	3	2	5	1	2	2	4	2	2	2	1	2	1	12	3	3	3	1	2	12	24	2	1	1	4	32
100	36	2	4	2	2	5	1	4	4	8	3	3	3	2	3	3	20	2	1	2	2	2	8	28	3	1	1	5	41
101	58	1	3	1	2	5	1	1	3	4	4	2	4	4	2	4	24	4	4	2	2	4	16	40	4	3	2	9	53
102	37	1	2	3	2	5	1	2	3	5	2	2	2	3	2	4	17	3	3	2	2	2	12	29	4	4	4	12	46
103	46	1	2	1	2	2	2	3	4	7	2	1	2	2	3	3	16	3	3	2	2	2	12	28	3	3	4	10	45
104	55	2	2	3	1	1	1	2	2	4	2	2	2	2	2	2	14	2	3	3	2	3	13	27	2	3	3	8	39
105	31	1	2	2	1	2	1	2	3	5	2	2	2	2	3	2	16	3	3	2	2	2	12	28	3	3	3	9	42
106	42	1	3	3	1	2	2	2	3	5	4	3	3	4	4	4	25	4	4	3	2	2	15	40	4	4	2	10	55
107	43	1	2	3	2	5	1	3	3	6	2	2	3	2	2	3	16	2	3	2	2	2	11	27	4	4	2	10	43
108	39	1	3	2	1	2	1	2	1	3	2	2	2	2	2	3	15	3	3	4	2	4	16	31	4	4	4	12	46
109	36	2	2	3	2	5	2	3	3	6	2	2	3	4	3	4	21	3	2	2	2	2	11	32	2	2	2	6	44
110	46	1	2	3	1	2	1	3	3	6	1	1	1	1	3	3	12	3	4	3	2	2	14	25	3	3	3	9	41
111	50	1	2	3	1	5	1	3	2	5	3	2	2	2	3	2	16	3	3	2	2	2	12	28	4	4	4	12	45
112	35	2	4	3	1	5	1	4	3	7	1	3	3	1	1	3	13	1	1	1	1	1	5	18	1	3	2	6	31
113	31	1	2	3	1	2	2	4	4	8	2	2	2	2	4	4	20	4	4	3	2	2	15	35	3	3	3	9	52
114	52	2	2	3	1	1	1	2	3	5	1	4	4	2	3	4	22	4	4	4	2	4	18	40	4	4	4	12	57
115	30	1	4	1	2	3	3	2	1	3	2	2	2	1	2	2	12	4	4	4	2	2	16	28	3	3	3	9	40
116	53	1	4	4	1	2	1	2	2	4	2	2	2	3	3	3	17	2	3	2	1	1	9	25	3	3	2	8	38
117	54	1	3	1	1	5	3	2	3	5	1	1	3	3	2	2	13	3	3	3	2	2	13	26	3	3	3	9	40
118	35	1	4	3	1	5	1	1	2	3	2	2	2	2	2	2	16	2	2	2	1	1	8	24	3	3	3	9	36
119	38	1	4	2	2	5	2	2	3	5	1	1	1	2	2	1	9	2	1	2	1	1	7	16	3	3	3	9	30
120	54	2	2	2	1	5	1	1	1	2	2	4	4	4	4	4	24	4	4	4	2	4	18	42	4	2	4	10	54
121	31	1	2	2	2	5	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	13	4	2	2	2	4	14	27	4	2	2	8	37
122	40	1	4	3	1	2	1	3	3	6	2	2	2	3	3	3	17	2	2	2	2	2	10	27	3	3	3	9	42
123	53	1	4	4	2	4	2	1	3	4	3	3	3	3	2	2	18	2	2	4	2	2	12	30	4	3	4	11	45
124	39	1	1	3	2	3	1	2	2	4	1	3	3	2	1	2	14	3	3	1	1	1	11	25	3	1	1	5	34
125	54	2	2	1	1	2	1	2	2	4	3	3	3	3	4	3	22	3	3	3	3	3	15	37	3	3	3	9	50
126	50	1	2	3	2	4	1	4	4	8	1	1	1	1	1	1	7	1	1	3	1	1	7	14	3	3	1	7	29
127	37	1	2	2	2	5	1	3	3	6	4	4	4	4	4	4	28	3	3	3	2	2	13	41	4	2	4	10	57

128	37	1	4	2	2	5	2	3	2	5	2	2	3	2	2	2	15	2	3	2	2	2	11	26	2	3	2	7	38	
129	38	2	3	2	1	2	2	2	2	4	2	1	1	2	2	1	10	3	3	3	2	2	13	23	4	4	4	12	39	
130	36	1	4	1	1	3	2	3	3	6	4	4	4	4	2	2	22	4	4	4	2	2	16	38	3	2	3	8	52	
131	33	1	3	2	2	2	2	1	2	4	6	2	3	4	2	2	1	15	2	3	3	1	10	25	3	3	1	7	38	
132	32	1	2	2	2	5	1	4	4	8	3	1	1	1	1	1	9	3	3	1	1	3	11	20	1	1	1	3	31	
133	47	1	2	2	1	1	1	3	3	6	2	4	4	4	2	2	20	2	4	2	2	4	14	34	2	4	4	10	50	
134	39	1	1	1	2	3	1	2	2	4	2	3	3	1	1	1	12	3	3	1	1	1	9	21	1	1	1	3	28	
135	42	2	4	3	1	3	2	3	3	6	2	2	1	2	1	2	12	3	3	1	1	2	10	22	3	3	3	9	37	
136	49	1	3	1	1	1	1	3	3	6	2	2	4	2	2	2	16	3	3	2	3	3	14	30	4	4	4	12	48	
137	42	1	2	3	1	2	1	3	3	6	2	1	2	1	1	1	9	3	1	1	3	3	11	20	3	3	3	9	35	
138	57	2	3	1	2	5	3	3	3	6	4	4	4	2	2	2	20	3	4	4	4	2	17	37	4	4	4	12	55	
139	30	4	2	2	5	3	3	3	3	6	3	1	1	1	1	1	9	2	2	2	1	1	8	17	1	1	1	3	26	
140	39	2	3	2	2	5	1	2	3	5	1	2	1	1	2	2	10	2	2	1	1	1	7	17	3	3	3	9	31	
141	59	2	2	3	2	5	1	2	2	4	2	1	2	1	1	3	11	1	1	2	1	2	7	16	3	3	3	9	31	
142	53	1	2	2	2	2	2	1	3	3	6	2	2	2	2	1	12	2	2	1	1	1	7	19	3	3	3	9	34	
143	59	1	4	1	1	3	3	3	3	6	1	1	1	1	1	1	8	2	1	1	1	1	6	14	2	1	2	5	25	
144	43	1	3	1	2	2	1	4	4	8	1	1	1	1	1	1	7	3	1	3	1	1	9	16	3	3	1	7	31	
145	36	2	3	3	2	2	2	2	2	4	1	1	2	1	1	1	8	3	1	1	2	2	9	17	3	3	3	9	30	
146	37	1	3	3	2	2	1	2	2	4	1	1	1	1	1	1	7	2	1	1	1	1	6	13	1	1	1	3	20	
147	57	1	1	1	1	3	1	2	2	4	4	4	4	4	4	4	28	2	3	3	4	4	16	44	4	4	4	12	60	
148	48	1	1	3	2	5	1	3	3	6	1	1	1	1	1	1	7	2	1	1	1	1	6	13	2	1	1	4	23	
149	39	1	2	2	1	2	1	3	3	6	1	1	1	1	1	1	7	2	1	1	1	1	6	13	1	2	1	4	23	
150	51	1	3	1	2	2	1	2	2	4	1	1	1	1	1	1	7	3	1	1	1	1	7	14	1	1	1	3	21	
151	42	2	3	2	2	2	2	4	4	8	1	1	1	1	1	1	7	2	1	1	1	1	6	13	3	3	3	9	30	
152	38	2	5	2	1	3	2	3	3	6	2	2	2	1	1	1	11	1	1	1	1	1	5	16	3	3	3	9	31	
153	57	1	1	1	1	2	1	3	3	6	2	2	2	2	2	2	14	1	1	1	1	1	5	19	1	1	1	3	28	
154	32	1	2	2	2	5	1	4	4	8	1	1	1	1	1	1	7	2	1	2	1	1	7	14	3	1	1	5	27	
155	30	1	2	3	2	5	1	3	3	6	1	1	3	2	3	2	14	2	1	3	4	4	14	28	4	2	3	9	43	
156	38	1	4	1	1	1	1	2	3	5	2	2	2	4	4	4	20	3	4	3	3	4	17	37	4	4	4	12	54	
157	46	1	3	2	2	2	1	4	4	8	2	2	1	1	1	1	9	1	1	1	1	1	5	14	1	1	1	3	25	
158	45	2	2	2	2	5	2	4	4	8	1	1	1	1	1	3	11	1	1	1	1	1	5	16	3	3	3	9	33	
159	58	1	2	1	2	5	1	2	3	5	1	1	1	1	2	2	1	9	3	3	3	1	2	12	21	1	3	3	7	33
160	57	1	4	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	5	12	4	3	3	10	24	
161	49	2	2	1	1	1	1	3	3	6	1	1	1	1	1	2	9	1	1	1	1	1	5	14	1	1	1	3	23	
162	34	1	3	3	2	3	1	3	2	5	1	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	5	12	1	1	1	3	20	
163	36	2	3	3	2	2	1	3	3	6	1	1	1	1	1	1	8	2	2	2	1	1	8	16	3	3	3	9	31	
164	35	2	4	3	2	2	1	3	2	5	1	1	1	2	2	1	9	1	1	1	1	1	5	14	3	3	3	9	28	
165	52	1	3	2	2	2	1	2	2	4	1	1	1	1	2	1	8	2	1	3	1	1	8	16	1	1	1	3	23	
166	58	1	3	2	2	2	1	3	3	6	1	1	1	3	3	1	11	3	1	3	1	1	9	20	3	4	4	11	37	
167	54	1	2	3	2	2	1	2	3	5	1	2	2	2	1	1	12	3	2	2	1	3	11	23	4	4	4	12	40	
168	38	1	3	1	2	1	1	4	4	8	1	1	2	2	2	2	14	3	3	4	3	4	17	31	4	3	4	11	50	
169	51	1	3	2	1	2	1	3	3	6	1	1	1	1	1	1	7	3	1	1	3	1	9	16	3	3	3	9	31	
170	47	1	3	1	2	2	1	2	3	5	2	2	2	2	2	2	14	2	3	2	4	4	11	25	4	4	4	12	42	
171	36	1	1	3	2	5	1	3	3	6	4	4	2	2	2	4	22	3	3	3	3	4	16	38	4	4	4	12	56	

217	33	2	3	2	2	3	1	3	2	5	2	2	2	2	2	2	14	2	2	2	2	2	10	24	3	3	3	9	38	
218	45	2	3	1	1	5	2	3	3	6	1	2	1	2	2	2	12	1	1	1	1	2	6	18	3	3	2	8	32	
219	34	2	3	2	1	3	3	3	2	5	2	3	3	4	2	2	4	20	3	3	3	1	1	11	31	3	3	2	8	44
220	53	1	2	1	1	2	1	2	4	6	4	4	4	4	1	1	22	4	3	1	1	1	10	32	4	4	4	12	50	
221	58	1	2	1	2	2	1	2	2	4	2	2	2	1	1	1	10	1	1	3	2	2	9	19	3	3	3	9	32	
222	40	2	3	3	1	2	1	2	2	4	1	2	2	2	2	3	14	2	2	2	1	1	8	22	4	4	4	12	38	
223	59	1	2	1	1	5	3	2	2	4	1	1	2	2	3	3	13	1	1	1	1	1	5	18	1	1	3	5	27	
224	35	1	2	2	2	5	1	2	3	5	3	1	1	3	3	3	17	4	4	3	1	1	13	30	1	1	1	3	38	
225	31	2	2	2	2	5	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	12	3	2	2	3	3	13	25	1	1	3	5	33	
226	42	1	3	1	2	2	3	3	3	6	3	3	3	3	3	2	2	19	3	3	3	1	1	11	30	3	3	3	9	45
227	59	2	3	1	1	2	1	2	2	4	1	1	1	1	1	1	7	2	2	3	1	1	9	19	3	3	3	9	29	
228	52	1	3	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	4	14	3	3	4	4	4	18	32	4	4	4	12	46
229	35	1	4	3	2	2	1	2	3	5	2	1	1	1	1	4	11	1	1	1	1	1	5	16	1	1	1	3	24	
230	52	2	3	1	1	1	1	3	3	6	1	1	1	1	1	1	7	1	1	3	3	3	11	18	3	3	3	9	33	
231	32	2	3	3	2	5	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	7	1	2	2	1	1	7	14	3	3	3	9	25	
232	41	1	2	2	1	3	1	3	3	6	3	3	2	2	2	2	16	2	2	3	1	1	9	25	3	4	4	11	42	
233	30	2	2	3	2	5	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	5	12	1	1	1	3	17	
234	31	2	2	2	2	5	1	1	2	3	1	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	10	23	2	3	2	7	33	
235	34	2	4	3	1	2	1	2	2	4	1	1	1	1	2	2	2	13	2	2	2	1	1	8	18	3	3	3	9	31
236	30	1	2	3	2	2	1	3	3	6	2	2	2	2	2	3	15	2	3	2	2	3	12	27	3	3	3	9	42	
237	36	1	2	2	2	5	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	14	3	2	3	2	3	13	27	4	4	4	12	41	
238	48	1	1	4	1	1	1	4	4	8	1	1	2	1	3	4	4	16	1	4	4	1	1	11	27	1	1	1	3	38
239	43	1	2	3	2	2	1	2	2	4	1	1	1	1	1	1	7	2	2	2	4	4	14	21	4	4	3	3	10	35
240	38	1	2	1	1	2	1	2	3	5	2	2	2	2	3	2	15	2	2	2	3	3	12	27	3	3	3	9	41	
241	31	1	2	2	1	1	1	3	3	6	3	1	1	1	2	2	3	13	3	2	2	2	1	10	23	3	1	3	7	36
242	38	1	2	3	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	9	2	2	2	1	4	11	20	3	3	3	9	31
243	59	1	4	2	2	5	1	2	2	4	1	1	1	1	1	4	10	1	1	1	1	1	5	15	1	3	3	7	26	
244	58	2	3	2	2	5	1	2	2	4	1	1	1	1	1	4	10	1	1	1	1	1	5	15	3	3	3	9	28	
245	37	1	4	1	2	5	1	3	3	6	2	2	2	2	2	2	14	2	2	2	3	3	12	26	2	2	2	6	38	
246	33	4	2	1	2	1	3	2	5	3	3	3	3	4	2	2	2	19	3	3	3	3	2	14	33	2	3	3	8	46
247	34	1	4	3	2	5	1	3	3	6	1	1	2	3	1	2	1	11	2	3	3	2	12	23	3	3	3	9	38	
248	44	1	3	1	1	1	1	3	4	7	2	2	2	2	2	1	1	12	2	2	2	3	1	10	22	2	2	2	6	35
249	40	2	2	2	1	5	2	2	3	5	2	2	2	2	2	3	15	2	2	2	2	1	10	25	2	3	3	9	39	
250	43	2	3	1	2	1	1	1	1	2	2	3	2	1	2	1	2	13	3	3	3	4	4	17	30	3	3	3	9	41
251	52	2	3	1	1	2	1	2	1	3	2	1	2	1	1	2	11	2	4	4	3	2	15	26	2	3	3	8	37	
252	35	2	2	2	2	2	2	1	4	1	5	1	3	4	1	1	1	12	3	2	1	2	3	11	23	1	3	1	5	33
253	39	1	3	2	1	5	1	3	2	5	1	1	1	1	1	1	7	1	3	4	1	1	10	17	3	3	3	9	31	
254	33	1	3	2	2	2	2	1	1	2	1	1	4	1	2	2	2	13	1	4	4	2	3	14	27	1	3	1	5	34
255	55	2	1	2	2	2	3	4	4	8	1	1	1	1	1	1	7	4	4	3	3	3	17	24	3	3	3	9	41	
256	33	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	10	2	2	3	1	2	10	22	4	2	4	10	34	
257	30	1	3	2	2	5	2	2	2	4	2	1	1	2	1	2	1	10	1	1	1	2	1	6	16	2	2	2	6	26
258	53	1	3	1	1	5	3	4	2	6	4	4	4	4	1	2	23	3	3	2	2	2	12	35	3	2	2	7	48	
259	36	1	3	3	2	3	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	9	3	3	3	2	2	13	22	3	2	3	8	32	
260	57	2	4	1	2	5	1	4	4	8	2	1	1	1	2	2	2	11	2	2	2	2	1	9	20	3	2	2	7	35
261	30	1	2	3	1	2	1	4	2	6	1	1	1	2	1	2	1	9	2	1	1	1	1	6	15	1	3	3	7	28

262	58	1	1	1	1	3	1	2	1	3	2	2	2	2	2	2	1	13	3	2	2	2	3	12	25	2	3	2	7	35
263	34	1	4	2	1	3	2	3	3	6	1	1	1	1	1	1	1	7	2	2	2	1	1	8	15	3	3	2	8	29
264	59	1	3	2	2	5	2	3	3	6	1	1	1	1	1	1	1	7	1	1	3	3	3	11	18	3	4	4	11	35
265	37	1	4	1	2	5	2	3	3	6	2	2	2	2	3	2	3	16	2	2	3	3	2	12	28	3	3	2	8	42
266	38	1	4	1	1	1	1	4	4	8	4	4	4	4	3	3	3	25	2	2	3	3	2	12	37	2	2	2	6	51
267	59	1	3	1	1	1	3	4	4	8	3	4	2	3	4	4	2	22	3	3	1	3	3	13	35	1	3	3	7	50
268	36	1	4	2	1	5	2	3	3	6	2	2	2	2	2	2	2	14	2	2	2	2	2	10	24	3	3	3	9	39
269	40	2	4	1	1	3	1	2	2	4	2	2	2	2	2	1	1	12	3	3	3	3	3	15	27	3	3	3	9	40
270	47	2	2	1	1	3	1	2	2	4	2	3	2	2	3	1	2	15	3	2	2	2	4	13	28	2	3	2	7	39
271	35	1	3	2	2	5	2	3	3	6	2	2	2	2	2	2	2	14	3	3	3	1	4	14	28	4	3	3	10	44
272	48	1	3	1	1	1	1	1	2	3	1	2	1	2	3	2	1	12	2	3	2	3	4	14	26	4	4	3	11	40
273	39	1	3	1	1	1	1	2	3	5	3	2	3	3	3	2	3	19	2	3	3	2	3	13	32	3	3	3	9	46
274	38	2	2	1	2	2	1	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	14	3	2	2	2	3	12	26	3	3	3	9	39
275	50	2	4	1	2	3	1	2	3	5	2	3	2	3	2	2	3	17	3	3	2	2	3	13	30	3	3	3	9	44
276	45	2	3	1	1	3	2	2	1	3	3	1	2	1	1	2	3	13	4	3	3	3	3	16	29	3	2	3	8	40
277	40	1	3	1	2	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	9	2	2	3	3	3	13	22	3	3	3	9	33
278	46	2	2	2	2	5	1	2	4	6	4	2	1	4	1	1	1	14	1	2	3	1	4	11	25	4	4	2	10	41
279	34	2	3	2	2	5	2	4	4	8	2	2	2	2	2	2	4	16	1	1	1	1	1	5	21	3	3	3	9	38
280	45	2	2	3	1	2	1	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	14	2	3	3	2	2	12	26	3	3	3	9	39
281	46	1	2	2	2	5	1	2	2	4	2	2	2	2	2	2	3	15	2	3	2	2	2	11	25	2	3	3	8	38
282	34	1	2	3	2	5	1	2	2	4	1	1	2	1	2	1	1	9	2	2	1	1	1	7	16	1	3	2	6	26
283	33	1	2	3	1	5	2	4	3	7	1	1	2	1	3	1	3	12	3	1	1	1	4	10	22	4	3	3	10	39
284	38	1	1	3	2	5	1	3	3	6	1	1	2	2	2	2	2	12	3	3	2	2	2	12	24	4	3	3	10	40
285	45	1	3	1	1	4	1	2	2	4	2	2	2	3	2	3	2	16	2	2	3	2	2	11	27	3	3	3	9	40
286	39	1	3	3	2	3	1	2	2	4	2	2	2	1	1	2	4	14	1	1	2	2	1	7	21	1	1	3	5	30
287	46	3	3	2	1	5	1	3	2	5	1	1	3	1	3	1	1	11	1	3	3	4	4	15	29	4	2	2	8	39
288	52	1	3	2	2	1	2	3	3	6	3	3	2	2	2	2	2	16	3	4	3	2	2	14	30	1	3	3	7	43
289	41	1	3	2	2	2	1	2	3	5	2	1	1	3	3	4	4	18	2	1	3	4	4	14	32	4	4	3	11	48
290	45	2	3	2	2	5	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	9	1	2	1	1	2	7	16	2	3	3	8	26
291	59	2	2	2	1	4	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	7	1	1	4	4	4	14	21	4	4	4	12	35
292	52	2	2	4	2	2	1	3	2	5	1	1	3	1	1	2	3	12	4	4	4	3	4	19	31	4	4	3	11	47
293	37	1	2	2	1	5	1	3	3	6	3	2	2	3	2	2	3	17	3	2	2	2	2	11	23	3	3	3	9	43
294	36	2	3	2	1	2	3	3	3	6	2	2	2	2	2	2	2	14	3	3	3	2	2	13	27	3	3	2	8	41
295	53	2	2	2	2	1	2	3	3	6	3	3	2	2	2	2	2	16	3	4	3	2	2	14	30	1	3	3	7	43
296	42	1	3	3	1	3	1	2	1	3	3	3	3	3	3	4	4	23	3	3	3	3	4	16	39	4	4	4	12	54
297	46	1	2	2	2	5	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	9	1	2	1	1	2	7	16	2	3	3	8	26
298	58	2	3	2	2	4	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	14	3	2	2	4	4	15	29	4	4	4	12	43
299	52	1	2	4	1	2	1	3	2	5	1	1	3	1	1	2	3	12	4	4	4	3	4	19	31	4	4	3	11	47
300	36	1	2	2	1	5	1	3	3	6	1	1	1	1	1	4	4	13	1	1	1	1	4	8	21	4	4	4	12	39

ANEXO G: Consentimiento Informado

Estimado usuario, soy Gianella Lezameta Estacio, Bachiller de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la Escuela de Enfermería, les presento el siguiente estudio titulado PERCEPCIÓN DE RIESGO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN ADULTOS QUE ACUDEN A UN CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 2024 que tiene como objetivo determinar la percepción de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2 en los adultos que acuden al C.S. Zárate entre los julio y agosto del presente año, para lo cual la información que usted brinde será importante y se manejará de manera confidencial.

Su participación es de manera voluntaria y consiste en responder la siguiente escala de Likert modificada que consta de 17 enunciados, lo que le tomará alrededor de 15 minutos poder contestar toda la escala, así mismo resaltar que los datos estarán bajo anonimato y confidencialidad.

¿Desea participar en el presente estudio? Sí ☐ No ☐

Se agradece su participación

ANEXO H: Tablas

Tabla 1. Datos generales de personas adultas que acuden a un Centro de salud en San Juan de Lurigancho, 2024

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS		
VARIABLE	CATEGORÍAS	N(%)
Edad	Media	42,7
Sexo	Femenino	197 (65,7)
	Masculino	103 (34,3)
Grado de instrucción	Primaria	20 (6,7)
	Secundaria	120 (40,0)
	Superior técnica	103 (34,3)
	Superior universitaria	57 (19,0)
Estado Civil	Soltero	111 (37,0)
	Casado	83 (27,7)
	Conviviente	91 (30,3)
	Viudo	15 (5,0)
Antecedentes familiares	Sí	128 (42,7)
	No	172 (57,3)
Presencia de enfermedades	Hipertensión arterial	35 (11,7)
	Sobrepeso	97 (32,3)
	Obesidad	36 (12,0)
	Otros	10 (3,3)
	Ninguno	122 (40,7)
Seguro de Salud	SIS	223 (74,3)
	EsSalud	58 (19,3)
	Otros	19 (6,4)